

PMPEA DE SUCRE 2022 – 2025

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. ENFOQUE POLÍTICO

1.1. Enfoques

- Enfoque de derechos humanos
- Enfoque de género
- Enfoque generacional
- Enfoque intercultural
- Enfoque interseccional

1.2. Marco conceptual

- Embarazo en adolescentes
- Educación Integral en Sexualidad
- Atención Integral Diferenciada
- Gabinete de Atención Integral a Estudiantes

1.3. Marco normativo nacional e internacional

- Constitución Política del Estado
- Convención de Derechos Humanos
- Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales
- Convención Americana sobre derechos humanos
- Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer
- Convención sobre los Derechos del Niño
- Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la violencia Contra la mujer
- Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo - El Cairo
- Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer - Beijing
- Consenso de Montevideo a partir de la Conferencia sobre población y desarrollo
- Cumbre del Milenio (2000)
- Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (2000)
- Ley 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez
- Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia
- Ley 348 – Ley para garantizar una vida libre de violencia
- Ley 342 de la Juventud
- Ley 548 - Código Niña, Niño y Adolescente
- Ley 512, Día Nacional de la Educación Sexual y Reproductiva Responsable
- Plan Plurinacional de prevención de embarazo adolescente y jóvenes 2015 – 2020
- Guía nacional para la atención diferenciada de adolescentes y jóvenes
- Protocolo de Prevención atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes
- Sentencia Constitucional 0206/2014
- Plan Andino para la Prevención y Reducción del Embarazo en Adolescentes 2017-2022,
- Ley Autonómica Municipal 120/2018 – Ley municipal de la niña, niño y adolescente de Sucre
- Ley Autonómica Municipal 047 – Ley para el desarrollo de la Juventud

2. DIAGNOSTICO

- 2.1. Ubicación geográfica**
- 2.2. Demografía**
- 2.3. Embarazo adolescente**
- 2.4. Violencia Sexual**
- 2.5. Noviazgos violentos**
- 2.6. Índice de Pobreza y necesidades básicas insatisfechas**
- 2.7. Migración**
- 2.8. Población económicamente activa**
 - 2.8.1. Trabajo Juvenil**
 - 2.8.2. Trabajo infantil y adolescente**
- 2.9. Cobertura educativa**
 - 2.9.1. Tasa de abandono escolar**
 - 2.9.2. Tasa de promoción anual**

3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

- 3.1. Objetivo Estratégico General**
- 3.2. Lineamientos de Acciones Estratégicas**
 - Educación Integral de la Sexualidad
 - Atención Integral Diferenciada para Adolescentes en Salud
 - Prevención de violencia sexual a niñas y adolescentes
 - Empleo y Emprendedurismo para Adolescentes y Jóvenes
 - Participación y Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles
 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
- 3.3. Matriz de planificación**
 - 3.3.1. Educación Integral de la Sexualidad**
 - 3.3.2. Atención Integral Diferenciada para Adolescentes en Salud**
 - 3.3.3. Prevención de violencia sexual a niñas y adolescentes**
 - 3.3.4. Empleo y Emprendedurismo para Adolescentes y Jóvenes**
 - 3.3.5. Participación y Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles**
 - 3.3.6. Fortalecimiento Institucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes**

4. ACTORES ESTRATÉGICOS

5. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

ANEXOS

Proceso participativo de elaboración del Plan Municipal

INTRODUCCIÓN

El presente “Plan de Prevención de Embarazo Adolescente PEA en el municipio de Sucre” se ha elaborado en un proceso participativo liderado por la Dirección de Juventudes del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en coordinación con el Consejo Municipal de la Juventud, y el Comité Municipal Interinstitucional de políticas públicas para la juventud, en respuesta a la Resolución que se emitió al identificar la urgente necesidad de abordar el problema del embarazo en adolescentes que se registran en el departamento de Chuquisaca en un promedio de 4 por día, de los que 2 se registran en Sucre, de acuerdo al Servicio Departamental de Salud.

Frente a esta preocupante situación, y en el marco de las competencias y atribuciones municipales, tomando en cuenta los lineamientos de planificación de la ley N° 777 del Sistema Integral de Planificación del Estado, y respondiendo al marco normativo nacional y autonómico y a los estándares internacionales de derechos, se plantea el presente Plan que ha sido elaborado participativamente en 4 fases:

- Fase de coordinación y organización: En la que se elaboró el Plan de trabajo, definiendo la Metodología y Cronograma de actividades, consensuados en reuniones técnicas con la Dirección Municipal de la Juventud – GAM Sucre y el Consejo Municipal de la Juventud. Además, se identificaron a los actores estratégicos. Y se difundió ampliamente el proceso participativo, mediante una Conferencia de Prensa de lanzamiento público de la Agenda de Recogida de Propuestas
- Fase de recojo de propuestas: Se realizó mediante diferentes eventos y herramientas participativas, en el marco de la Sesión del Comité Municipal Interinstitucional de Políticas Públicas de la Juventud; Reunión con el Consejo Municipal de la Juventud de Sucre y organizaciones juveniles y de niñez y adolescencia; Buzón digital (Formulario On line) y Audiencia Pública de recogida de propuestas; y entrevistas individuales a actores estratégicos.
- Fase de sistematización de propuestas: Mediante el Trabajo de Gabinete donde se sistematizó el diagnóstico en base a datos oficiales, el marco normativo y las propuestas presentadas elaborando el documento borrador del Plan Municipal de Prevención de Embarazo Adolescente PEA en el municipio de Sucre.
- Fase de validación: Con el Consejo Municipal de la Juventud y organizaciones juveniles, el equipo técnico de la Dirección de Juventudes y de diferentes unidades del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y las entidades que conforman el Comité Municipal Interinstitucional de Políticas Públicas de la Juventud.

El presente Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes del Municipio de Sucre, ha sido elaborado participativamente desde un enfoque de derechos humanos, género, generacional e intercultural, en el marco de la asistencia técnica que brinda UNFPA al Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con la elaboración e implementación de normativas autonómicas de juventudes como la Ley Municipal N° 047 – Ley Autonómica Municipal para el Desarrollo Integral de la Juventud, y su aplicación con la creación de la Dirección Municipal de la Juventud y el Comité Municipal Interinstitucional de políticas públicas para la juventud. Dentro del sexto programa país 2018-2022 que ejecuta actualmente el Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Bolivia.

1. ENFOQUE POLÍTICO

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, reconoce el importante bono demográfico de niñas, niños y adolescentes, que representan el 38% de la población del municipio de Sucre, e identifica que se requiere un necesario desarrollo de políticas públicas, que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos.

En este marco, se identifica el embarazo en adolescentes como uno de los problemas prioritarios de atención en el municipio, que requiere una planificación estratégica preventiva, a partir acciones de alto impacto que promuevan una respuesta desde la participación ciudadana y el involucramiento de las y los adolescentes y jóvenes como actores principales, sujetos de derechos, que puedan ser partícipes de una intervención intersectorial, que permita brindar una respuesta integral desde el Estado como garante de derechos, con participación de las familias y la comunidad, como corresponsables.

En este sentido, el presente Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes del Municipio de Sucre, busca contribuir a que las adolescentes y jóvenes, puedan acceder a espacios educativos y a servicios de información, orientación y atención de salud, que contribuyan a que tengan un proyecto de vida, que promueva su desarrollo integral, en el que en su juventud o adultez, cada embarazo sea planificado y deseado, en el marco del ejercicio de un desarrollo afectivo y sexual con responsabilidad y sin ningún tipo de violencia.

1.1. Enfoques

El Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes del Municipio de Sucre se desarrolla desde el enfoque de fortalecimiento del ejercicio de derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con atención a su desarrollo integral y a los derechos a la participación ciudadana, a la salud, educación, a vivir una vida libre de toda forma de violencias, con atención prioritaria a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad mediante la generación de políticas públicas de atención, prevención y restitución de sus derechos, desde los enfoques de derechos, género, generacional, intercultural e interseccional.

Enfoque de derechos humanos, que parte de la importancia de incluir en el centro de las políticas públicas a los sujetos de derechos, en el presente caso las niñas y adolescentes, como titulares de derechos que deberán ser garantizados por el Estado en sus diferentes niveles, es decir municipal, departamental y nacional, en corresponsabilidad con la familia y la comunidad que son los responsables de respetar los derechos asumiendo los deberes y obligaciones que les correspondan de acuerdo al caso.

En este sentido, el enfoque de derechos, supera el enfoque asistencial, resaltando la participación ciudadana de las y los titulares de derechos desde una óptica de exigibilidad que impone la justicia social.

Enfoque de género se Alejandra Faúndez (2010) lo define como “aquel que permite describir la situación relativa y las relaciones de poder entre las mujeres y los hombres en sus diferentes ámbitos: la familia, el trabajo, la comunidad y la vida pública y señalar las limitaciones y las oportunidades que mujeres y hombres (de diferentes grupos socioeconómicos o culturales) enfrentan por sus roles de género y la posición que ocupan en la sociedad. Permite, asimismo, distinguir entre los aspectos de un problema que afectan a toda una población y los efectos diferenciales para las mujeres y/o los hombres que pueden causar desventajas o rezagos a lo largo del ciclo de vida. Es decir, aquello que afecta su condición y posición en la sociedad por razones de género por tener en cuenta las características, intereses y necesidades diferenciadas

de hombres y mujeres en atención a la corrección de los desequilibrios de poder entre los sexos y favorecer la igualdad de oportunidades y garantizar igualdad de derechos”¹.

Enfoque generacional como herramienta de análisis que considera el diferente impacto de las políticas públicas como los planes y programas en las diferentes etapas del ciclo vital de una persona.

Enfoque intercultural “está orientado al reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades actuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos como pueblos (...) El enfoque de interculturalidad está orientado a abordar las particularidades de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la coexistencia de culturas”².

Enfoque interseccional: “tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes tipos de identidad”³

1.2. Marco conceptual

Embarazo en adolescentes

De acuerdo a los especialistas de salud, la edad más apropiada para ser madre es entre los 20 y los 35 años, debido a que el riesgo para la salud de la madre y el niño es mucho menor.

El **embarazo en adolescentes** se produce generalmente en mujeres de 15 a 19 años, y se considera de alto riesgo. Aunque en determinados casos se registran embarazos entre los 10 y los 19 años.

Varios autores e investigaciones identifican que el embarazo en adolescentes se produce por diferentes circunstancias que pueden estar relacionadas a múltiples causas como los factores biológicos relacionados al desarrollo físico y hormonal; a factores conductuales relacionados a la iniciación sexual precoz, falta de conocimiento o acceso a anticonceptivos, drogas o alcohol y presión de la pareja o social; a factores emocionales como baja autoestima o dependencia afectiva; factores socioculturales relacionados a los estereotipos de género, machismo, falta de proyectos de vida, influencia mediática; factores familiares como la falta de comunicación entre padres y madres e hijos/as, falta de supervisión, uniones precoces forzadas; o a hechos delictivos relacionados a la violencia sexual (Guía para la maestra y el maestro. Educación Integral en Sexualidad. IPELC. 2020)

El embarazo en la adolescencia tiene serias consecuencias en la vida de las adolescentes, relacionadas a diferentes ámbitos de su proyecto de vida, como:

¹ Alejandra Faúndez (2010). Manual para la transversalización del enfoque de igualdad de género en el ciclo de proyecto. Departamento de Planificación y Evaluación de la OEA, Washington D.C.

² UNFPA-PNUD-UNICEF-ONU Mujeres. Ampliando la mirada: La integración de los enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos. 2012.

³ AWID. Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. 2004.

- La salud, debido a que existen mayores riesgos en la salud de la madre adolescente y del/la niño/a, porque existen mayores posibilidades de que se produzca la mortalidad materno infantil. Ya que, por ejemplo, la anemia y el parto prematuro son más frecuentes en la madre adolescente. Por otro lado, el parto podría ser muy prolongado e incluso complicarse por la posible estrechez de la pelvis a esa edad, estas complicaciones obstétricas están casi siempre relacionadas con la inmadurez biológica de la adolescente, que todavía no ha completado el crecimiento y desarrollo de los órganos del aparato reproductor.
- La salud mental, debido a que genera un importante cambio en la vida de la adolescente que puede enfrentar a raíz del embarazo una ruptura de sus proyecciones personales, problemas con la familia, puede generarle miedo a ser rechazada, baja autoestima, entre otros.
- La educación, debido a que puede causar la deserción o abandono escolar.
- La incorporación temprana al trabajo, debido a que las adolescentes tienen nuevas responsabilidades de manutención de sus hijos/as y muchas veces enfrentan la crianza solas, sin apoyo del padre o su propia familia, y tienen que trabajar además de estudiar.

Educación Integral en Sexualidad

El Ministerio de Educación de Bolivia e IPELC definen que la Educación Integral en Sexualidad (EIS) como el enfoque basado en un marco de derechos, que busca equipar a las y los jóvenes con los conocimientos, aptitudes, actitudes y valores integrados en competencias que necesitan para determinar el desarrollo integral de la personalidad, para lograr la vivencia de una sexualidad saludable, responsable y respetuosa del/la otro/a.

Identifica a la sexualidad de manera holística y como parte del desarrollo emocional y social de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, por lo que la Educación Integral en Sexualidad además de brindarles la información que necesitan adquirir, contribuye a la formación de aptitudes esenciales para la vida, desarrolla actitudes y valores positivos, en síntesis, habilidades para la vida.

Es un proceso formativo, continuo, permanente y participativo que se desarrolla en todos los ámbitos, espacios de la vida y en las familias, a lo largo del ciclo de la vida tiene como objetivo brindar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollar una visión positiva y saludable de la sexualidad y la afectividad en un marco de derechos, en su desarrollo físico, emocional, espiritual y social. Desde la coeducación y el interaprendizaje, para la toma de decisiones responsables basadas en información completa y precisa, promoviendo relaciones más armoniosas intra e inter género y generacional.

Atención Integral Diferenciada

La Atención Integral Diferenciada es un modelo de atención en salud que contempla la atención especializada del personal para la atención de adolescentes, la accesibilidad a las infraestructuras de salud, el involucramiento de adolescentes y jóvenes en la formación y procesos de réplica entre pares y la articulación interinstitucional.

“La Atención Integral Diferenciada al Adolescente, consiste en que el personal médico y administrativo e integrantes de un centro de salud, brinden al o la adolescente atención especializada multidisciplinaria acorde a su edad, con calidad, calidez y respeto a su identidad, orientación sexual, identidad de género, valores, condición social, cosmovisión, idioma, cultura, que genere confianza y seguridad, sin discriminación alguna”.

Gabinete de Atención Integral a Estudiantes

“El Gabinete de Atención Integral a Estudiantes (GAIE), es un servicio Psicosocial integral y de orientación en Educación Integral de la Sexualidad (EIS) que promueve el desarrollo de aprendizajes en sexualidad en la unidad educativa, con la familia y la comunidad (...)

Dirige sus acciones a las/os estudiantes del municipio: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes del área concentrada y dispersa, con énfasis en las/os estudiantes de secundaria.

También desarrolla acciones informativas en sexualidad con madres y padres de familia y la comunidad; y de apoyo a maestras/os para el desarrollo de su trabajo en EIS en las unidades educativas”⁴.

El GAIE se articula con los servicios de salud, al sistema de protección, compuesto por Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Servicios Legales Integrales Municipales, Policía, programas de instituciones públicas y privadas u organizaciones de sociedad civil.

1.3. Marco normativo nacional e internacional

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con importantes avances en la construcción de normativas y políticas públicas de reconocimiento de los derechos y la protección integral a las niñas, niños y adolescentes, a partir de un tratamiento diferenciado tomando en cuenta todas sus necesidades, aspiraciones e intereses que son distintos a la población adulta en general, por sus condiciones particulares de desarrollo, dentro una realidad social que, a pesar del amplio marco normativo garante de derechos nos muestra una constante vulneración a los mismos.

En este marco, la **Constitución Política del Estado** establece el reconocimiento de los derechos reconocidos, sin distinción alguna y establece la prohibición de toda forma de discriminación incluyendo el sexo, la edad y la condición de embarazo, garantizando el goce y ejercicio de estos derechos en condiciones de igualdad (Artículo 14 CPE), describe los derechos de las niñas, niños y adolescentes como titulares de los derechos reconocidos en la Constitución (Artículo 58).

Además, reconoce los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, garantizando la adopción de las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (Artículo 15 CPE)

Así mismo, la Constitución Política establece el derecho a la salud (Artículos 18 y 35 CPE) y la garantía de mujeres y hombres al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos (Artículo 66 CPE).

Y en el marco de las competencias autonómicas determina que los Gobiernos Autónomos Municipales tienen como competencias exclusivas la promoción del desarrollo humano, la (Artículo 302.2. CPE) y la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad (Artículo 302. 39. CPE).

Finalmente, la Constitución Política del Estado, reconoce en el Bloque de Constitucionalidad los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. (Artículo 410 CPE).

⁴ UNFPA. Dirección departamental de educación de Chuquisaca. 2017. Manual para el funcionamiento del Gabinete de Atención Integral a Estudiantes. GAIE.

Detallamos a continuación los **INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR BOLIVIA** más importantes en relación a la prevención del embarazo en adolescentes, los derechos sexuales y derechos reproductivos y el derecho a la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes:

La **Convención de Derechos Humanos** (1948), que establece los derechos y la obligación de los Estados de respetarlos y de promover la paz a partir de la educación de los Derechos Humanos en todo el mundo.

El **Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales** (1966), que reconoce, entre otros el derecho de los seres humanos a la educación y a la salud.

La **Convención Americana sobre derechos humanos** (1969), además de establecer el sistema interamericano de defensa de derechos, abre el debate sobre el derecho a la vida.

La **Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer** – CEDAW (1979) establece que los Estados partes garantizaran a la mujer una vida libre de toda forma de discriminación y violencia, definiendo que el estado tomara todas las medidas para “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos”, y para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, define lineamientos para el acceso a la educación sin discriminación.

También establece los derechos de la mujer a la información sobre planificación familiar, a servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fueren necesarios, y asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia, además establece el derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos, y determina finalmente que “No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”.

Posteriormente el Comité de la CEDAW ha generado una serie de recomendaciones al Estado Boliviano y de estándares internacionales, como la **Recomendación General N° 35** en la que, entre otros, establece que “La violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas” y que “Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, la tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto, la continuación forzada del embarazo y el abuso y el maltrato de las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”.

Determinando también la importancia de “proporcionar reparaciones efectivas a las víctimas y supervivientes de la violencia por razón de género contra la mujer, y estableciendo que las reparaciones deberían incluir diversas medidas, tales como la indemnización monetaria, la

prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, incluidos servicios de la salud sexual, reproductiva y mental para una recuperación completa, y la satisfacción y garantías de no repetición”

La **Convención sobre los Derechos del Niño** (1989) y sus protocolos facultativos que determinan derechos en los ámbitos de supervivencia, desarrollo, participación y protección integral, estableciendo la necesidad de la protección y cuidados especiales a las niñas niños y adolescentes para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.

La **Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la violencia Contra la mujer** - Convención de Belém Do Pará (1994) Desarrolla el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, estableciendo las garantías que debe determinar el Estado.

La **Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo - El Cairo** (1994), donde se definió el término de "derechos reproductivos" como aquellos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y salud reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia.

La **Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer - Beijing** (1995), donde se incluye a la salud sexual como parte de la salud reproductiva y se establece que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y decidir libremente respecto a estas cuestiones, sin coerción, discriminación y violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen respeto y el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual.

El **Consenso de Montevideo a partir de la Conferencia sobre población y desarrollo** (2013) que define una serie de acuerdos entre los que se encuentran los compromisos relativos a sexualidad y reproducción, educación integral para la sexualidad desde la primera infancia.

La **Cumbre del Milenio** (2000) y la **Agenda del desarrollo** (2015), inicialmente establecen ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el propósito de garantizar un desarrollo económico sostenible, de ellos tres se refieren a: igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducción de la mortalidad en la infancia y al mejoramiento de la salud materna. Y posteriormente definen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, entre los que destacamos los que abordan: el fin de la pobreza; el acceso a la salud y bienestar – que incluye el indicador de la tasa de fecundidad en adolescentes, identificando el embarazo en adolescentes como una de las causas de mortalidad materna y los efectos adversos de los niños de madres adolescentes como por las consecuencias en la salud y desarrollo de las madres adolescentes y establece una meta para garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales - ; a la educación de calidad; a la igualdad de géneros– que insta a la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, el fin de todas las formas de discriminación de género y la eliminación de las prácticas nocivas como

el matrimonio infantil, precoz y forzado y define una meta específica para asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos-.

La **Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes** (2000) que reconoce en su artículo 23 el “Derecho a la educación sexual” como fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y sus consecuencias. Misma que debe impartirse en todos los niveles educativos para fomentar una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a su plena aceptación e identidad, así como, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH (Sida), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual.

Determinando que los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual de los jóvenes. Debiendo adoptar e implementar políticas de educación sexual, estableciendo planes y programas que aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho.

El Estado Boliviano ha desarrollado una serie de **NORMATIVAS NACIONALES** garantes de derechos que contribuyen a los diferentes compromisos adquiridos al ratificar los diferentes instrumentos internacionales, entre las que destacamos las siguientes:

Ley 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez (2010) define que, “en los Planes y Programas intersectoriales y articuladores relacionados con educación, y que constituyan prioridades del Estado Plurinacional, deberán ser implementados por el Sistema Educativo Plurinacional a través de planes de acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemática en los distintos componentes del Sistema. Constituyendo prioridades: Educación sin violencia, educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de la Madre Tierra, educación contra el racismo, educación en valores y ética” (Disposición Adicional Décima segunda).

Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia (2013) que define las “Atenciones de Salud Sexual y Reproductiva. Son todas las acciones destinadas a la prevención y tratamiento de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino, así como la orientación y provisión de métodos de anticoncepción voluntaria y libremente consentida, el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y aquellas priorizadas por el Ministerio de Salud y Deportes, que guarden estrecha relación con una maternidad segura”, incluye entre los beneficiarios de atención a las mujeres durante el embarazo hasta 6 meses después del parto y a niños menores de 5 años (Artículos 3.7) y 5. L475).

La **Ley 348 – Ley para garantizar una vida libre de violencia** (2013) establece una serie de medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. Además, define que el ministerio de salud y deportes deberá Generar y difundir información permanente y actualizada sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, hemorragias durante el primer trimestre de embarazo, embarazos no planificados y de todas las formas de violencia sexual. (Artículo 20. 8. L348).

La **Ley 342 de la Juventud** (2013), que contempla como titulares de derechos a toda persona mayor de 16 años y reconoce como parte de los derechos sociales, económicos y culturales de los jóvenes el acceso a información y formación, en todos los ámbitos de la salud, derechos sexuales y derechos reproductivos, estableciendo en su que las entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus competencias, deberán desarrollar políticas de educación para la

sexualidad, responsable en todos los niveles educativos, centros de salud pública y privada, así como también garantizar a las jóvenes y los jóvenes el derecho a ser informados y educados en salud sexual y salud reproductiva, para mantener una maternidad y paternidad responsable, sana y sin riesgos. (Artículo 38 L342)

La **Ley 548 - Código Niña, Niño y Adolescente** (2014), establece derechos, garantías y mecanismos de protección, de toda forma de violencia incluida la violencia sexual, el derecho del acceso a servicios diferenciados en salud sexual y salud reproductiva y a la educación sexual, además de acciones concretas de prevención del embarazo en adolescentes, de acuerdo al siguiente detalle:

- Define el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir atención médica de emergencia. (Artículo 21 L548)
- Establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a la salud sexual y salud reproductiva, determinando que el estado en todos sus niveles, debe garantizar el desarrollo de procesos de información, sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos reproductivos, sexualidad integral y servicios de atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva, mediante servicios diferenciados. Definiendo que las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud sexual y reproductiva de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, de parte de su padre o madre y dentro del sistema educativo. (Artículo 22. I y II L548)
- Define las acciones para la prevención del embarazo en adolescentes, dando la tuición al Ministerio de salud para coordinar dichas acciones con las entidades territoriales autónomas, así como la tarea de establecer de manera quinquenal un índice de embarazo adolescente, instando a las entidades territoriales autónomas la realización de acciones y reasignaciones presupuestarias necesarias, si su índice de embarazo adolescente es mayor al índice nacional. El (Artículo 23 L548)
- Determina la obligación de los hospitales y establecimientos de salud públicos y privados a Brindar consejería eficaz a las adolescentes, así como un servicio respetuoso y no revictimizador a las madres adolescentes víctimas de violencia sexual. (Artículo 25 incisos e) y f) L548)
- Establece que el Sistema Educativo Plurinacional debe garantizar a las niñas, niños y adolescentes acceso a información adecuada y formación oportuna en educación sobre sexualidad integral. (Artículo 116 L548)
- Define la realización de acciones intersectoriales de atención, información integral, consejería y educación sobre salud sexual y salud reproductiva, infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, con énfasis en las niñas, niños y adolescentes en situación de calle y los Procedimientos para la atención oportuna de interrupción legal de embarazo, que contemplen, además, mecanismos de información y acompañamiento y atención psicoterapéutica a las niñas o las adolescentes víctimas de violencia sexual. (Artículo 13 del Decreto Supremo N° 2377 Reglamento de la ley 548).

Ley 512, (2014) que declara el 4 de septiembre como Día Nacional de la Educación Sexual y Reproductiva Responsable y establece que “El Órgano Ejecutivo y las Entidades Territoriales Autónomas en el marco de sus competencias, en coordinación con las instituciones públicas y privadas involucradas, implementarán programas, campañas, ferias, talleres, seminarios de información integral, respetuosa y preventiva en cuanto a la educación en salud sexual y reproductiva responsable” (Artículo 2 L512).

En el marco de la normativa vigente, en Bolivia se han desarrollado una serie de **POLITICAS PUBLICAS NACIONALES**, como planes, programas, protocolos, guías y manuales, entre los que destacamos los siguientes:

El **Plan Plurinacional de prevención de embarazo adolescente y jóvenes 2015 – 2020** se encuentran contemplados 6 pilares dentro de los que se deberán enmarcar las acciones de prevención del embarazo adolescente en todo el territorio nacional siendo estos pilares los siguientes:

- Revolución económico productiva y laboral.
- Revolución para una educación en derechos sexuales y derechos reproductivos.
- Revolución para un servicio de salud diferenciada y de calidad propone.
- Revolución para una vida libre de violencia.
- Revolución ciudadana para la participación.
- Revolución institucional para políticas públicas integrales.

La **Guía nacional para la atención diferenciada de adolescentes y jóvenes** (2013), establece los lineamientos para el abordaje desde un enfoque diferenciado de la sexualidad con adolescentes y jóvenes y la salud sexual y salud reproductiva, en donde se reconoce que la sexualidad y la salud sexual y reproductiva (SSyR), la anticoncepción y el embarazo adolescente son temas importantes para los y las adolescentes, y ocupan un lugar central en su vida, por lo que el personal de salud debe conocer los términos utilizados en los ámbitos de la sexualidad humana y la salud sexual, con el fin de facilitar la comunicación con los/las adolescentes y jóvenes.

El **Protocolo de Prevención atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes** (2013) que desarrolla un conjunto de procedimientos específicos que describen la forma cómo las entidades públicas, privadas, instituciones de la sociedad civil y la familia, con la participación de las niñas, niños y adolescentes, deben actuar para garantizar a las víctimas de violencia sexual la restitución de sus derechos.

Determinando que las medidas que deben asumirse para proteger la integridad física y salud de la niña víctima de violencia sexual que como resultado de la violación, incesto o estupro hubiesen quedado embarazadas es la de: “Aplicarse de manera inmediata tratamiento para la prevención de Hepatitis B, ITS, VIH/Sida. Y, en caso de encontrarse en edad reproductiva, se deberá ofrecer Anticoncepción de Emergencia para prevenir el embarazo. Y a sola presentación de copia de la denuncia, los servicios de salud privados o públicos deberán proceder a la interrupción legal del embarazo cuando la niña o adolescente víctima de agresión sexual así lo requiera” de acuerdo a la Sentencia Constitucional 0206/2014.

Sentencia Constitucional 0026/2014 modifica el artículo 266 del Código Penal referido al aborto impune que señalaba: “Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios. En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso”.

A partir de la SCP 0206/2014 fue declarada la inconstitucionalidad de las frases: “siempre que la acción penal hubiese sido iniciada” y “autorización judicial en su caso”. En ese sentido, las niñas o adolescentes que como resultado de la violación, incesto o estupro hubiesen quedado embarazadas, únicamente deberán presentar una copia de la denuncia efectuada para que el servicio de salud (público o privado) proceda a realizar la interrupción legal del embarazo.

Así mismo, exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a diseñar políticas y crear normas que precautelen los derechos sexuales y derechos reproductivos.

Finalmente, también es importante mencionar como política internacional el **Plan Andino para la Prevención y Reducción del Embarazo en Adolescentes 2017-2022**, que reconoce el Embarazo en Adolescentes como un problema de salud pública, de derechos humanos y desarrollo. Que preocupa a los países de la región andina por las consecuencias negativas en el desarrollo de las y los adolescentes en los diferentes ámbitos de salud, educación, empleo y devalúa la vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Definiendo 4 objetivos de intervención:

- Desarrollar el diagnóstico de la situación del embarazo en adolescentes en la subregión.
- Identificar modelos de atención que garanticen superar las barreras de acceso y capacidad resolutoria en el sector de salud.
- Promover la participación de las y los adolescentes a través de intercambio de experiencias.
- Sensibilizar a autoridades, sociedad civil, comunicadores y proveedores de salud sobre la importancia de contar con acciones políticas que permitan la prevención del embarazo en adolescentes.

Objetivos para los que se definen 4 líneas de acción: 1. Sistemas de información, monitoreo y evaluación. 2. Fortalecimiento institucional y cooperación técnica horizontal. 3. Participación de adolescentes. 4. Abogacía, Alianzas y Participación Social. Dentro del marco del Objetivo General del plan que es “Contribuir a la prevención y reducción del embarazo en adolescentes de la Subregión Andina, elevando a política de estado de los países miembros, una estrategia multisectorial de prevención y reducción del embarazo en adolescentes, con acceso y cobertura universal a servicios amigables de salud sexual y reproductiva, con participación y veeduría de los jóvenes en el marco del cumplimiento de los ODS 2030 y en línea con otros acuerdos regionales, entre ellos, el Consenso de Montevideo”

Tomando en cuenta todo ese marco normativo nacional e internacional, el municipio de Sucre cuenta con un **MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO**, del que destacamos las siguientes leyes desarrolladas por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre:

La **Ley Autonómica Municipal 120/2018 – Ley municipal de la niña, niño y adolescente de Sucre** (2018), la cual establece en el marco de sus competencias que, como Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, elaborará, desarrollará e implementará políticas públicas para la prevención del embarazo en adolescentes con especial énfasis en aquellos adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad; además de capacitar y sensibilizar al personal que trabaje con adolescentes embarazadas, en las etapas prenatal, parto y postnatal buscando un trato cálido y sin discriminación, garantizando la atención diferenciada (artículo 9 LAM120/2018)

Además, identifica la prevención del embarazo adolescente, como una de las prioridades para elaborar el Plan municipal de la niña niño y adolescente de Sucre. (Artículo 22 inciso f LM120/2018)

La **Ley Autonómica Municipal 047 – Ley para el desarrollo de la Juventud** (2014), reconoce como uno de los derechos de la juventud de Sucre (jóvenes mayores de 16 años), el derecho a estar debidamente informados sobre planificación familiar, educación sexual y reproductiva. (Artículo 9, inciso 7 LAM047/2014)

Establece que el Gobierno Autónomo Municipal, debe garantizar programas de orientación y educación sexual integral, servicios de salud integral con atención diferenciada, salud sexual y reproductiva gratuita y prevención de embarazos no planificados en jóvenes. (Artículo 10, inciso 3. LAM047/2014)

Describe que el Plan municipal de la juventud que se constituye en el instrumento de gestión pública para la implementación de políticas específicas en materia de juventudes contemplando temas como salud integral, atención diferenciada, salud sexual y reproductiva, prevención de embarazos no planificados, entre otros (Artículo 26 LAM047/2014).

Y establece los lineamientos para las políticas públicas municipales, contemplando la Implementación de programas integrales de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva, en todos los niveles educativos, el apoyo y fortalecimiento a las organizaciones juveniles, que trabajan en el empoderamiento y liderazgo en la temática de la salud bio-psico-social y salud sexual y reproductiva la promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva, brindando educación e información gradual y oportuna sobre temas de sexualidad y acceso a métodos anticonceptivos, para fortalecer el plan de vida y mantener una maternidad y paternidad responsable, sana y sin riesgos.

Así como la necesidad de contar con personal de salud especializado para una atención diferenciada y de calidad y espacios específicos con material informativo interactivo sobre salud, salud sexual y reproductiva. (Artículo 31 LAM047/2014)

2. DIAGNOSTICO

2.1. Ubicación geográfica

El Municipio de Sucre se encuentra en el departamento de Chuquisaca, que se extiende con una superficie de 51.524 km². Y se encuentra ubicado en el sudeste del país. Limita al norte con los Departamentos de Potosí, Departamento de Cochabamba y el Departamento de Santa Cruz; al sur con el Departamento de Tarija; al este con el Departamento de Santa Cruz y la República de Paraguay y al oeste con el Departamento de Potosí.

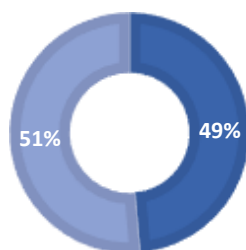
Sucre cuenta con una superficie de 1.876,91 km². y forma parte de la unidad geomorfológico denominada "Cordillera Andina Oriental". La topografía por tanto es disectada, con predominancia de cerros y montañas y reducidas superficies planas aptas para cultivo, situadas en la zona norte de la sección y en terrazas de ríos. El clima dominante es templado sub – húmedo.

2.2. Demografía

En relación al Municipio de Sucre, de acuerdo a las proyecciones al 2020 se estima una población de 353.996 habitantes, (treientos cincuenta y tres mil novecientos noventa y seis) equivalente al 54,1 % de la población en Chuquisaca que es de 654.035 habitantes (de acuerdo a las proyecciones poblacionales - revisión 2020, UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística.) Del total de habitantes de Chuquisaca el 49% son Hombres y el 51% son mujeres.

POBLACION DE CHUQUISACA

■ hombres ■ mujeres

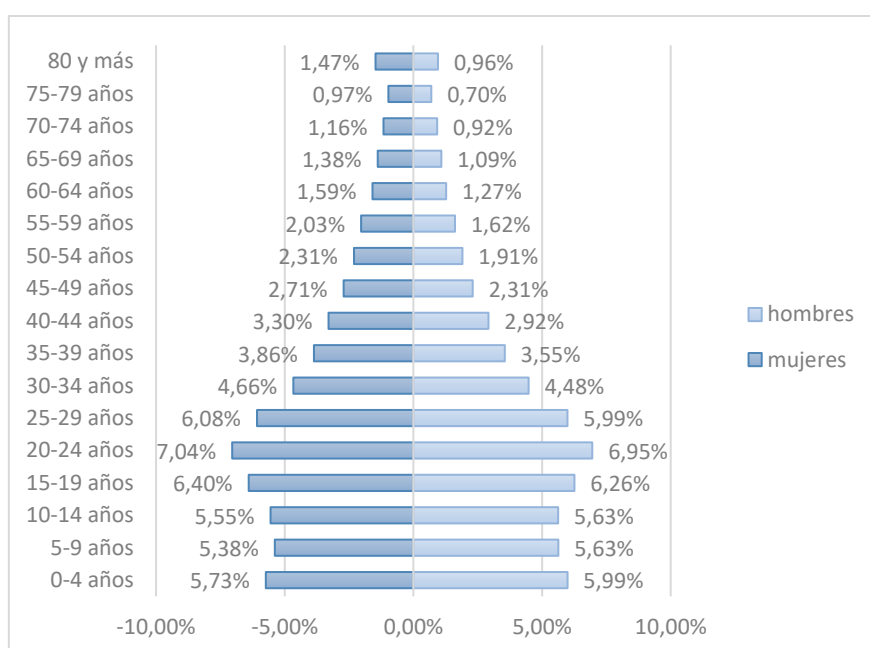


Fuente. UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, proyecciones poblacionales - revisión 2020

En Sucre el 48,6% de la población son hombres y el 51,4% mujeres, de acuerdo a las proyecciones poblacionales - revisión 2020.

Sucre es un municipio Joven, del total de la población de Sucre 137.627 son infantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 19 años que equivalen al 38.88% de la población total del municipio.

Pirámide Poblacional Municipio de Sucre



Fuente. UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, proyecciones poblacionales - revisión 2020

De acuerdo a las proyecciones poblacionales - revisión 2020, UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 19 años de Sucre:

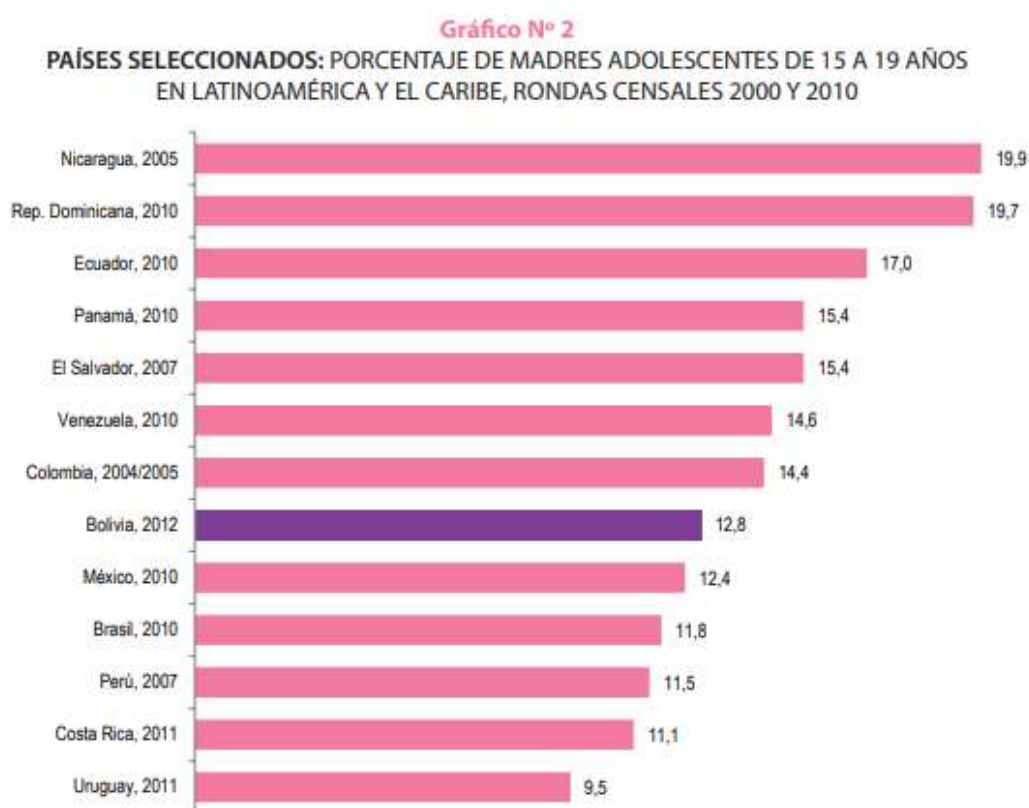
- El 25,2% son infantes de 0 a 4 años (34.648)
- El 23,7% son niños y niñas de 5 a 9 años (32.557)
- El 24% son niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años (33.019)
- Y el 27,2% son adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años (37.403).

Del total de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 19 años de Sucre el 50,1% son hombres y el 49,9% son mujeres, (UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, proyecciones poblacionales - revisión 2020)

Finalmente es muy importante mencionar que, del total de la población de 0 a 19 años, el 51,2% tiene entre 10 a 19 años, contando con un importante porcentaje de población adolescente que enfrenta diferentes situaciones y problemáticas como el embarazo adolescente.

2.3. Embarazo adolescente

De acuerdo al Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia elaborado por el INE, Bolivia se ubica en el grupo de países con mayor tasa de fecundidad en la adolescencia; si bien, la Tasa Específica de Fecundidad (TEF) adolescente no alcanza a los valores de algunos países de Centroamérica, claramente está por encima de los países vecinos.



Fuente: Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia, en base a EDSA 2008-2016

De acuerdo a la CEPAL, **BOLIVIA** tiene un porcentaje de 12,4 de madres de 15 a 19 años para el 2014, índice que ha subido progresivamente a 13% en 2014, continúa incrementándose a 14,8% el 2016, llegando a incrementarse al **16,5%** en 2021 de acuerdo a datos del Ministerio de Salud y Previsión social que reportó: *“A Septiembre del 2021 los embarazos en adolescentes representan a un 16.5% en el país, lo que significa que al menos 104 adolescentes por día quedan embarazadas y de esa cantidad 6 son niñas menores de 15 años”*⁵

Según datos del Sistema Nacional de Información, en la gestión 2019 se registró 49.044 embarazos en adolescentes, en 2020 se llegó a 39.945, mientras que hasta julio de 2021 la cifra

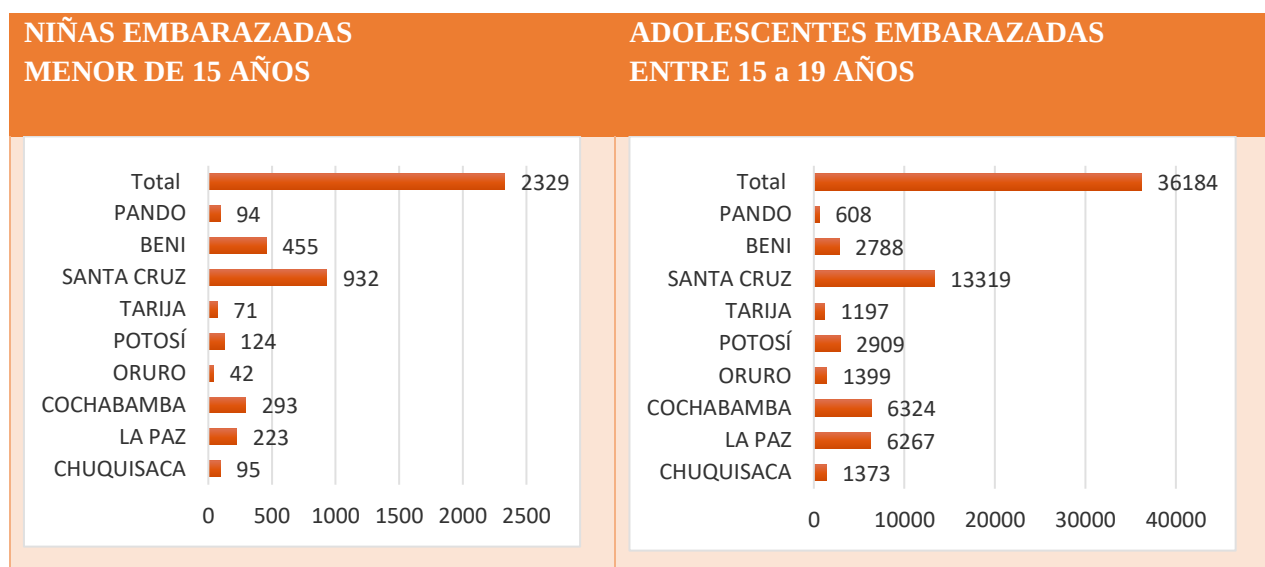
⁵ <https://www.minsalud.gob.bo/es/6078-salud-promueve-encuentro-nacional-de-adolescentes-y-jovenes-para-prevenir-embarazo-no-deseado>

asciende a 38.477 embarazos en niñas y adolescentes menores de 18 años el 2021. Lo que equivale a un promedio de 105 por día; en tanto, en menores de 15, hubo 2.329 gestaciones, un promedio de 6 por día.

A esas preocupantes cifras, se suma el hecho de que más del 50.5% en el área urbana y el 58,6% en el área rural, es decir, más de la mitad de las madres tuvieron embarazos no intencionales en Bolivia⁶. Dato que se desprende de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016, que revela que más de la mitad de las mujeres bolivianas que fueron consultadas no había decidido ser madre cuando quedó embarazada, sino que quería ejercer su maternidad más tarde (28,9%), o ya no quería tener más hijos o solo no quería ser madre (21,6%).

De acuerdo a UNFPA en base a proyecciones de EDSA 2016, el 2021 en **BOLIVIA** se registraron un total de 38.477 embarazos en adolescentes. De los que se registraron a 36.184 adolescentes entre 15 a 19 años y 2329 adolescentes menores de 15 años.

Embarazos en Adolescentes en Chuquisaca



Fuente: PTDI Chuquisaca con información UNFPA en base a EDSA 2016

Del total de adolescentes embarazadas en Bolivia, el 4% se encuentran en **CHUQUISACA** situando al departamento en el 6to lugar con mayor número de adolescentes embarazadas en relación al resto de los departamentos del país.

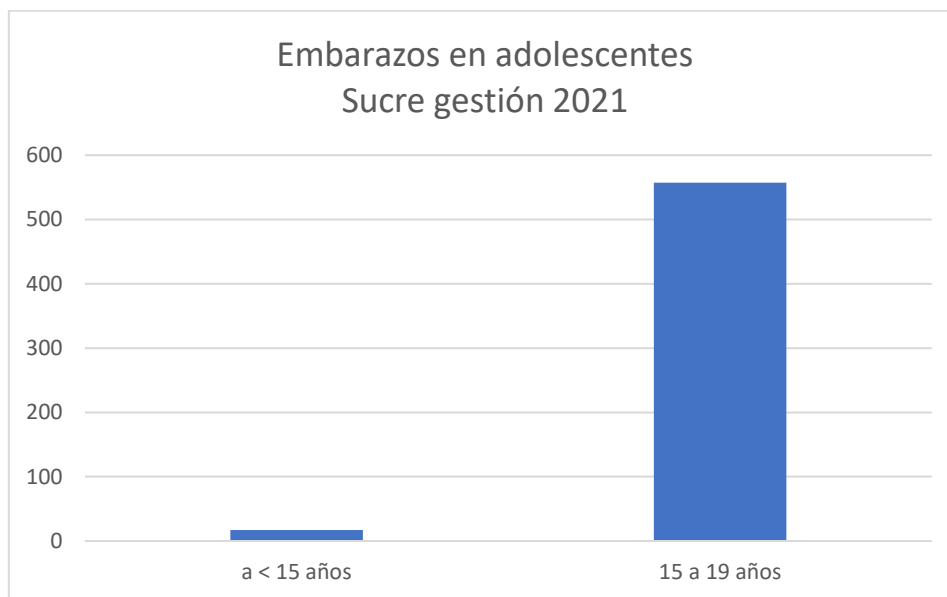
De acuerdo a estos datos, en **CHUQUISACA** se registraron un total de 1.468 embarazos en adolescentes menores de 19 años, de los que se registraron a 1373 adolescentes entre los 15 y 19 años, y 95 niñas y adolescentes menores de 15 años.

Según EDSA 2016 “las adolescentes que ya son madres llegan al 13,6%, que descendió con relación al 2008 (16,6 %). Los mayores porcentajes se presentan en adolescentes de 17 a 19 años, con nivel de educación primaria, del área rural, que aprendieron a hablar en quechua y grados de pobreza alta y baja”.

De acuerdo al Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca, en el departamento se registran un promedio de 4 embarazos por día, de los que 2 se registran en el Municipio de Sucre.

⁶ Fondo de Población de Naciones Unidas. UNFPA. 2022. Estado de la Población Mundial 2022.

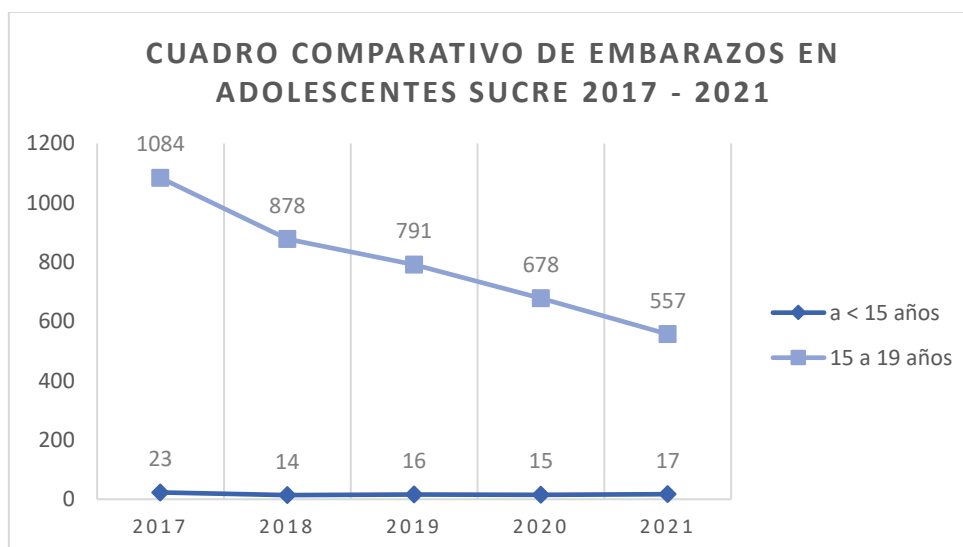
En el municipio de **SUCRE** en la gestión 2021, se registraron un total de 574 embarazos en adolescentes menores de 19 años.



Fuente: UNFPA en base a datos del INE. 2021.

De los 574 embarazos en adolescentes que se registraron en Sucre:

- 557 fueron embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años edad (97%).
- 17 embarazos fueron en niñas y adolescentes menores de 15 años en edad (3%).



Fuente: UNFPA en base a Datos del INE. 2017 a 2021.

Embarazo en Adolescentes en el Municipio de Sucre 2017 a 2021

Año	2017	2018	2019	2020	2021
Embarazos en adolescentes	1107	892	807	693	574

Fuente Servicio departamental de Salud de Chuquisaca

Los datos comparativos de embarazo en adolescentes en Sucre entre el 2017 al 2021, reflejan que se produjo una reducción progresiva de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en el Municipio de Sucre.

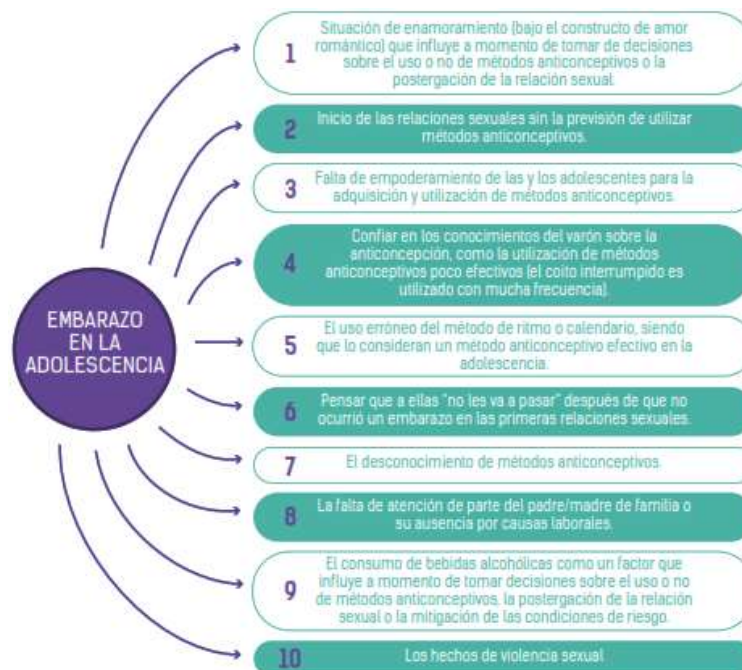
Sin embargo, llama la atención que a pesar de que se produjo una reducción importante de embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años entre el 2017 y el 2018, se ha vuelto a producir un ligero incremento progresivo de embarazos en menores de 15 años entre el 2018 y el 2021.

En datos absolutos, en relación a la gestión 2020 se observa un incremento al 2021 de 2 casos en embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años. Sin embargo, en relación a embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años se observa una reducción de más de 100 casos, del 2020 al 2021.

El “Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia” (2016) realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas UNFPA nos muestra una realidad desde la percepción de las adolescentes encuestadas, denotando importantes respuestas a ser tomadas en cuenta entre las que destacamos:

- El primer embarazo acontece entre los 13 a 19 años, generalmente por iniciativa de los adolescentes hombres.
- La percepción sobre los factores que promueven el embarazo en la adolescencia es diversa, y va desde aspectos culturales que tienen que ver con el “amor romántico” que es transmitido culturalmente mediante canciones o cuentos infantiles y sitúa a la adolescente mujer en una posición de dependencia afectiva y emocional que puede contribuir a aceptar tipos de violencia o la “prueba de amor” respondiendo a la presión de la pareja de tener relaciones sexuales a temprana edad, hasta la falta de conocimiento y uso inadecuado de los métodos anticonceptivos por falta de información o limitada comunicación con los padres y madres en temas de salud sexual y salud reproductiva, o incluso por situaciones ligadas al consumo de alcohol y drogas o a delitos de violencia sexual.

En el mencionado estudio se identifican los siguientes factores relacionados al embarazo en la adolescencia:



Fuente: UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016.

En relación a estas percepciones es importante identificar que las mismas coinciden con los factores asociados a la variable de "alguna vez estuve embarazada" identificados por el "Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia" (2018) elaborado por el INE, que refiere los siguientes:

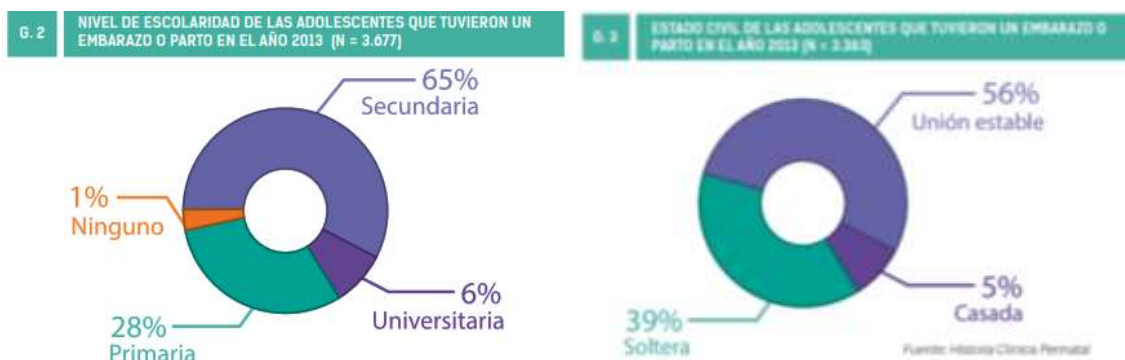
- Haber sufrido violencia en la pareja
- Tener un nivel menor de instrucción alcanzado (de 0 a 6 años)
- Haber iniciado la actividad sexual antes de los 15 años
- Hablar en otros idiomas (quechua, aymara)
- No tener acceso a Métodos anticonceptivos modernos

Veamos algunos datos respecto a dos de estos factores: el inicio temprano de la actividad sexual y la violencia de pareja, que implican mayor riesgo de que las adolescentes se embaracen cuando:

- Iniciaron su actividad sexual antes de los 15 años (67% estuvieron embarazadas, en relación a un 50% de las que iniciaron su actividad sexual después de los 15 años).
- Sufrieron violencia por parte de su pareja (el 100% de menores de 15 años y el 91% de mayores de 15 años, que sufrieron violencia de pareja se embarazaron, a diferencia del 55% de menores de 15 años y 41% de mayores de 15 años que no sufrieron violencia de pareja)

De acuerdo a las historias Clínicas⁷ el 27% de las adolescentes se autoidentifican como indígenas y el 48% como mestizas.

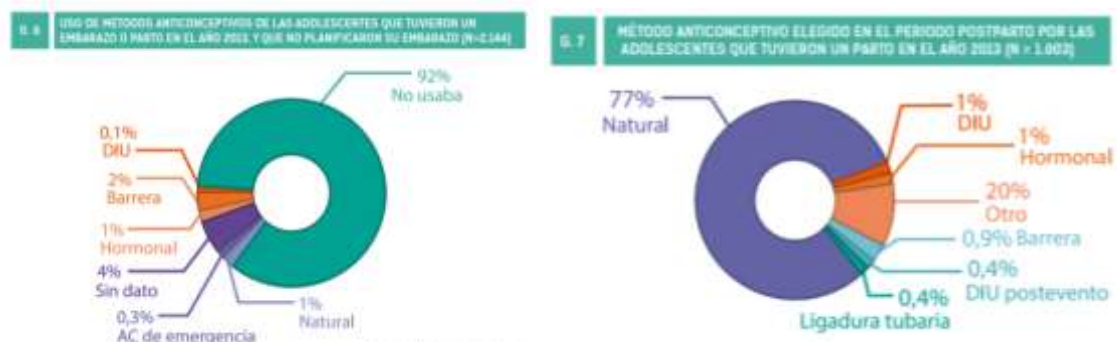
⁷ UNFPA. 2016. "Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia".



La mayor parte de las adolescentes que tuvieron un embarazo o un parto y participaron en el estudio, están en el nivel secundario de educación (65%). Llama la atención el hecho de que casi 3 de cada 10 adolescentes embarazadas estén en el nivel de educación primaria (28%). Y una minoría ya está en la Universidad (6%).

Por otro lado, se puede identificar que 4 de cada 10 adolescentes embarazadas están solteras (39%). Y la mayoría, 6 de cada 10, viven con su pareja en Unión libre (56%) o está Casada (5%).

Respecto a la Planificación Familiar (que es el derecho que tienen las personas a decidir libremente cuando y cuantos hijos tener) y el Uso de Anticonceptivos, es importante resaltar que la mayor parte de los embarazos en adolescentes no son planificados, ya que solo el 2 de cada 10 adolescentes planificaron su embarazo (24%), y 5 de cada 10 adolescentes no planificaron su embarazo (54%).

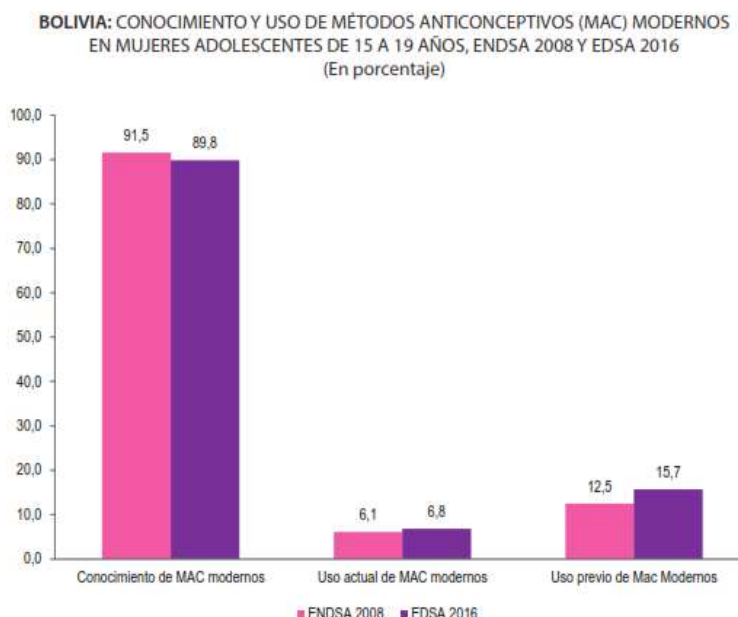


Fuente: UNFPA. Estudio sobre el Embarazo en la Adolescencia en 14 Municipios de Bolivia. 2016.

Por otro lado, se puede identificar que entre las adolescentes que no habían planificado su embarazo:

- 9 de cada 10 no usaba ningún tipo de método anticonceptivo, es decir el 92%; y solo el 5% usaba el método de barrera (condón) o métodos hormonales.
- Casi 8 de cada 10 adolescentes recibió orientación en métodos anticonceptivos después del parto, es decir el 79%; Y solo el 66% de ellas eligió usar un método anticonceptivo. Pero el 77% eligieron el método natural (Ritmo, coitus interruptus o método de lactancia y amenorrea), y solo el 5% eligió algún método anticonceptivo moderno (DIU, Hormonal, Barrera y en menor proporción la ligadura tubaria)

Estos datos se relacionan a los datos nacionales que reportan como a pesar de que las mujeres adolescentes de 15 a 19 años conocen los métodos anticonceptivos modernos, no los utilizan con frecuencia.



Fuente: INE. Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia. 2018.

El Estudio el “Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia” (2018) elaborado por el INE, muestra que el 89,8% de las adolescentes de 15 a 19 años conocen los Métodos Anticonceptivos Modernos, pero solo el 6,8% usa los mismos y el 15,7% uso Métodos Anticonceptivos Modernos alguna vez en el pasado. Estas cifras se incrementan cuando las variables se analizan en adolescentes de 15 a 19 años “alguna vez embarazadas”:

BOLIVIA: PORCENTAJE DE MUJERES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS ALGUNA VEZ EMBARAZADAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, ENDSA 2008 Y EDSA 2016
(En porcentaje, número y puntos porcentuales)

CARACTERÍSTICA SELECCIONADA	ENDSA 2008		EDSA 2016		DIFERENCIA EN PUNTOS PORCENTUALES 2016-2008
	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	
Usa actualmente MAC modernos	20,6	130	25,5	87	4,9
Usó alguna vez MAC modernos	41,2	260	58,3	200	17,1 ✓
Tiene acceso a MAC modernos	30,7	194	25,9	89	(4,8)
Conocen MAC modernos	91,7	579	89,7	307	(2,0)
Edad de inicio de actividad sexual antes de 15 años	30,6	193	26,2	90	(4,4)
Edad de inicio de actividad sexual a los 15 años o más	68,8	435	73,8	252	5,0
Violencia de la pareja	40,6	256	32,3	111	(8,3) ✓
Vive en hogar NO estructurado	7,1	45	6,7*	23	(0,4)
Ningún nivel de instrucción alcanzado o primaria	51,2	323	16,3	56	(34,9) ✓
Nivel de instrucción secundaria o superior	48,8	308	83,7	286	34,9 ✓

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008 y Encuesta de Demografía y Salud 2016

(*) Con coeficiente de variación superior a 20%, emplearlo solo de forma referencial.

✓ Corresponde a diferencias entre proporciones estadísticamente significativas con un nivel de confianza de 95 por ciento.

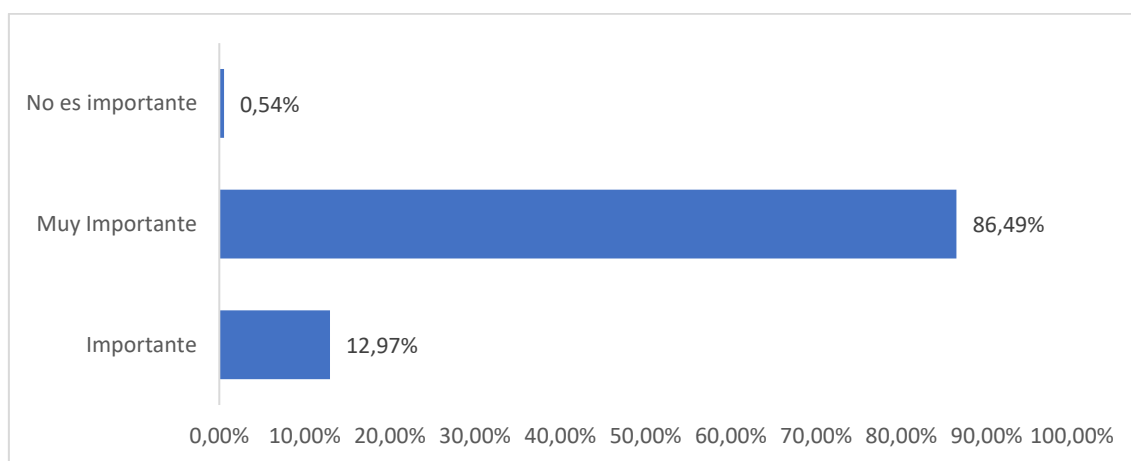
Fuente: INE. Estudio temático del embarazo adolescente de Bolivia. 2018.

En relación a las adolescentes entre los 15 a 19 años “alguna vez embarazadas” se puede identificar que casi 9 de cada 10, es decir el 89,7%, conocen Métodos Anticonceptivos Modernos, y caso 6 de cada 10, es decir el 58,3% alguna vez uso los mismos, pero solo el 2 de cada 10, es decir el 25,5% los usa actualmente. Hecho que nos muestra a pesar de conocer los

Métodos anticonceptivos Modernos los usan poco, pero el uso se incrementa en aproximadamente un 20% después de que se han embarazado alguna vez.

Estos datos preocupan porque los índices de violencia sexual, la migración generada principalmente por la situación de pobreza y la limitada oferta educativa del nivel secundario, técnico y universitario en las áreas rurales, el consecuente trabajo infantil y adolescente y la actividad laboral en trabajos prohibidos y peligrosos, son factores que se constituyen en causas, pero también son consecuencias del embarazo en adolescentes. Situación que preocupa debido a que se genera un círculo de pobreza que se afianza, produciendo una mayor vulnerabilidad.

Importancia de la Educación Sexual Integral para los jóvenes



Fuente: Dirección de Juventudes GAM Sucre. Relevamiento de información (2022)

En relación con el anterior gráfico, las y los jóvenes respondieron en un 86% que la educación integral sexual es muy importante, un 13% respondió que es importante, mientras que el 1% respondió que no tiene importancia

2.4. Violencia Sexual

De acuerdo al EDSA 2016, 3 de cada 10 adolescentes de 15 a 19 años alguna vez embarazadas, fue víctima de violencia de pareja. En este sentido, queda claro que una de las principales causas del embarazo en adolescentes es la violencia sexual.

La violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes “es ejercida por una asimetría de poder, desde una posición de privilegio o dominación, utilizando la manipulación psicológica, el chantaje, el engaño, el uso de la fuerza, basada en un vínculo de dependencia afectiva, emocional y/o económica”⁸ y es la segunda tipología de violencia que se produce con mayor frecuencia tanto en Bolivia como en Chuquisaca.

En Bolivia la violencia es un fenómeno que se incrementa año a año, de acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado, en relación a los delitos de violencia en razón de género en el marco de la ley 348, en 2020 se reportaron 38.089 casos de violencia y en 2021 se registraron 45.174 hechos de violencia hacia la mujer.

⁸ Ministerio de Justicia y transparencia institucional de Bolivia. Protocolo de prevención, atención y sanción a toda forma de vulneración a la integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes.

Delitos de violencia en razón de género en el marco de la Ley 348 en Chuquisaca

Año	2018	2019	2020	2021
Chuquisaca	1.827	1.844	1.731	2.465
Violencia familiar o doméstica	1.451	1.380	1.324	1.907

Fuente: Fiscalía General del Estado de Bolivia

Al igual que en Bolivia, en el departamento de Chuquisaca, se reporta un incremento anual de violencia pasando de 1.731 casos denunciados en 2020 a 2.465 casos de violencia denunciados en 2021, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado. De los que 1324 en 2020 y 1.907 en el año 2021 fueron casos de violencia familiar o doméstica.

Tipología de violencia sexual contra la mujer en Bolivia 2021

Delitos	2018	2019	2020	2021
Violación	138	152	121	167
Estupro (Art. 309)	52	77	86	73
Violación infante niña, niño y adolescente (Art. 308 bis)	66	94	107	154
Abuso Sexual (Art. 312)	70	87	86	109

Fuente: Fiscalía General del Estado de Bolivia

La primer tipología que se produce con mayor frecuencia en Chuquisaca, de acuerdo a los datos oficiales es la violencia sexual expresada en diferentes formas, que afecta principalmente a las mujeres y a las niñas, y se produce en el 80% en el ámbito familiar.

De acuerdo a EDSA 2016:

- El 20% de las mujeres en Bolivia ha experimentado violencia física o sexual, y al 6% la han forzado a tener relaciones sexuales.
- Así mismo, el 4,8% de las mujeres adolescentes entre los 15 a 19 años ha sido forzada a tener relaciones sexuales por parte de alguien diferente a su pareja, el 6,2% ha sido forzada a tener relaciones sexuales por parte de su pareja y el 5,5% se embarazo producto de la agresión.

De acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, se identifican 4 tipos de violencia sexual que se producen con mayor frecuencia:

- 227 casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años (154 son delitos de violación a niña, niño y adolescente, 73 son delitos de Estupro)
- 167 casos de violación a mujer.
- 126 casos de otras formas de violencia Sexual (109 Abuso Sexual, 2 acoso político, 12 Acoso Sexual, 3 actos sexuales abusivos y agravantes)

Llama la atención que de las adolescentes mujeres de 15 a 19 años que sufrió violencia, solo el 36,7% busco ayuda en una persona cercana, y solo el 5,2% busco ayuda de una institución (EDSA 2016).

No se cuentan con datos oficiales desagregados de violencia por municipios, sin embargo, si tomamos en cuenta que el 54% de la población del departamento de Chuquisaca habita en el municipio de Sucre, se puede suponer que de los 227 casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes que se producen en el departamento mas de 100 se producen en el municipio de Sucre.

2.5. Noviazgos violentos

De acuerdo a los datos de la Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres (2016) el 74% de las mujeres de 15 años o más en Bolivia vive o ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su relación y el 44% en los últimos 12 meses.

Según los datos de EDSA 1016, el 43% de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años, casadas o unidas, han experimentado por lo menos una situación de violencia por parte de su pareja en Bolivia en los últimos 12 meses.

Tipo de violencia en adolescentes de 15 a 19 años en Bolivia

CARACTERÍSTICA SELECCIONADA	TIPO DE VIOLENCIA POR PARTE DE LA PAREJA		
	Emocional	Física	Sexual
Grupo de edad			
15-19	43,0	17,8	6,2*

Fuente: EDSA 2016

Las mujeres adolescentes entre 15 a 19 años, casadas o unidas que han sufrido algún tipo de violencia afirman que en el 43% se produjo violencia emocional, en el 17,8% violencia física y en el 6,2% de casos sufrieron violencia sexual por parte de su pareja.

En Chuquisaca. de acuerdo a los datos de la Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres (2016):

- El 74% de las mujeres de 15 años o más, refiere que vive o ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su relación, de acuerdo al tipo: 98% psicológica, 13% física y 23% sexual.
- Y el 37% en los últimos 12 meses, de acuerdo al tipo de violencia: 84% psicológica, 33% física y 27% sexual.

De acuerdo a EDSA 2016 el 41% de mujeres casadas o unidas, han experimentado por lo menos una situación de violencia por parte de su pareja en Chuquisaca en los últimos 12 meses– el 41,8% violencia emocional, el 21,7% violencia física y el 11,9% sexual -.

Muchas veces la violencia que se genera dentro de las relaciones de pareja no son percibidas por las adolescentes y jóvenes como tal, por la naturalización de la violencia al interior de las familias, por los estereotipos de género que naturalizan relaciones de poder relegando a la mujer a un rol de codependencia económica, familiar (por los/as hijos/as) de servicio y labores domésticas y “atención a la pareja e hijos” y emocional y por la idea del “amor romántico”, entre otros.

Existen mecanismos individuales y sociales que sostienen la producción, reproducción y tolerancia a hechos de violencia; frente a los cuales se pueden ofrecer herramientas que

eduquen a la juventud para erradicar las situaciones violentas en el contexto de relaciones interpersonales “Es necesario alertar a las/os jóvenes acerca de la violencia mediante la cual pueden ser objeto en sus noviazgos; para prevenir e identificar la violencia de género, a través de la desnaturalización y deconstrucción de los estereotipos impuestos por la sociedad; construyendo relaciones en términos de igualdad, promoviendo la importancia de los buenos tratos; como la comunicación, el respeto e igualdad.”⁹

2.6. Índice de Pobreza y necesidades básicas insatisfechas

Población por condición de necesidades básicas insatisfechas en Sucre

Condición de necesidades básicas insatisfechas		Población	Distribución porcentual
Población Total		251.648	100.0
No pobre	NBS	102.411	40,7
	Umbral	81.616	32,4
Pobre	Moderada	56.260	22,4
	Indigente	10.911	4,3
	Marginal	450	0,2
Porcentaje de población Pobre		26,9	

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Según los últimos datos oficiales del censo de 2012, se identificó en el municipio de Sucre que el 40,7% de la población tiene las necesidades básicas satisfechas, el 32,4% se encuentra en el umbral de la pobreza y el 26,9% es pobre y se clasifica en tres categorías: Moderada con el 22,4%, indigente con 4,3% y marginal con 0,2%.

2.7. Migración

La tasa de migración neta intercensal (2.001 – 2.012) se ha incrementado, de manera general, en todos los departamentos; el departamento de Chuquisaca ocupa el 5to puesto con un 6,36% de emigrantes. El 6,36% representa a 31 029 (treinta un mil veinte nueve) migrantes según los datos del censo de 2012, donde el 48% son mujeres y 52% varones.

Los lugares a los que migra la población del departamento con mayor frecuencia se vinculan con el objetivo de la migración (generalmente estudio o trabajo).

La migración en busca de mejores condiciones de vida y fuentes de trabajo, de acuerdo a importancia se produce hacia los siguientes departamentos o países: Santa Cruz, Argentina, Tarija, España, Cochabamba, Chapare, Sucre, Brasil y otros. Con el objetivo de estudio es más Sucre, Santa Cruz y Tarija.

Asimismo, se constató que el 3,6% (78.391 inmigrantes) de la migración absoluta entre municipios que tienen ciudades capitales de todos los departamentos del País llegan a Sucre.¹⁰

⁹ Programa educativo de Montevideo, basado en la resolución municipal N° 14277 de agosto de 2012, es una herramienta de acción preventiva contra la violencia de género desde las primeras fases del noviazgo entre los/as adolescentes acorde a las convenciones internacionales y leyes nacionales, provinciales y locales.
<https://www.facebook.com/La-violencia-no-es-amor-490918747754503/>

¹⁰ <https://www.ine.gob.bo/index.php/sucre-ocupa-el-quinto-lugar-en-poblacion-de-las-ciudades-capitales/>

Inmigrantes absolutos en el municipio de Sucre

Municipio	INMIGRANTES					
	Total	% Sobre el total de inmigrantes	Del mismo departamento		De otros departamentos	
			Inmigrantes	%	Inmigrantes	%
Sucre	78.391	3,6%	19.847	25,3%	58.544	74,7%

Fuente: Elaboración propia en base a Migración Interna en Bolivia, INE, 2012.

Es así que el municipio de Sucre recibe principalmente migrantes que provienen de otros departamentos (74,7%) y en menor porcentaje de municipios del mismo departamento al que pertenecen (25,3%).

Por otro lado, respecto a la Emigración, en Chuquisaca el 21,8% de los emigrantes se dirigió a municipios del mismo departamento y el 78,2% muestra mayor preferencia a destinos fuera del departamento

Emigrantes absolutos en el municipio de Sucre

Municipio	EMIGRANTES					
	Total	% Sobre el total de emigrantes	Del mismo departamento		De otros departamentos	
			emigrantes	%	emigrantes	%
Sucre	69.792	3.2%	7.902	11,3%	61.890	88,7%

Fuente: Elaboración propia en base a Migración Interna en Bolivia, INE, 2012.

Así mismo se observó que el 3,2% del porcentaje total de emigrantes a nivel nacional salen de Sucre. Es así, que el 11,3% sale de Sucre a municipios del mismo departamento, mientras que el 88,7% sale a municipios de otros departamentos.¹¹

2.8. Población económicamente activa

Se pudo clasificar a 105.973 personas del Municipio de Sucre clasificadas en 7 categorías, donde el 42% (45.541) son obreros o empleados, en segundo lugar, el 37% trabajadores por cuenta propia, el 3% es empleador o socio/a, al igual que el 3% que es trabajadora familiar o aprendiz sin remuneración, también se identificó que el 2% son trabajadoras/es del hogar, el 1% que son cooperativistas de producción o servicios y el 9% sin especificar.

Población empadronada de 10 años o más de edad, según categoría ocupacional

Categoría ocupacional	Total	Hombres	Mujeres
Total	105.973	58.845	47.128
Obrero/a o empleado/a	45.541	27.235	18.306
Trabajadora/or del hogar	2.638	34	2.604
Trabajadora/or por cuenta propia	40.118	22.281	17.837
Empleador o socio/a	3.513	2.186	1.327
Trabajadora/or familiar o aprendiz sin remuneración	3.315	1.679	1.636
Cooperativistas de producción/servicios	633	353	280
Sin especificar	10.215	5.077	5.138

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

¹¹ <https://www.ine.gob.bo/index.php/publicaciones/migracion-interna-en-bolivia/>

Las actividades económicas en el municipio más frecuentes según los datos del censo de 2012, de acuerdo a la siguiente tabla son: el comercio y transporte de almacenes que equivale al 27% (28.640) del total de las actividades económicas, así mismo la construcción con un 12% (13.422), la industria manufacturera con el 9% (10.479), la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura el 6% (7.727) y con mayor porcentaje otros servicios no especificados con el 35% (36.868). Sobre las 3 actividades económicas principales, los hombres tienen mayor participación y presencia en las mismas: comercio, transporte y almacenes el 52%, construcción el 97%, e industria manufacturera el 61%.

Población empadronada de 10 años o más de edad, según actividad económica

Actividad económica	Total	Hombres	Mujeres
Total	105.973	58.845	47.128
Agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura	7.727	5.081	2.646
Minería e Hidrocarburos	468	424	44
Industria manufacturera	10.479	6.404	4.075
Electricidad, gas, agua y desechos	276	238	38
Construcción	13.422	13.033	389
Comercio, transporte y almacenes	28.640	15.021	13.619
Otros servicios	36.868	14.622	22.246
Sin especificar	3.389	1.680	1.709
Descripciones incompletas	4.704	2.342	2.362

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

De la población de 10 años o más que trabaja la mayor parte de los hombres trabajan en comercio, transporte y almacenes, seguido del ámbito de la construcción y la industria manufacturera. Y de las mujeres, la mayoría también trabaja en comercio, transporte y almacenes, seguido de la industria manufacturera y la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura.

Características Ocupacionales de la Población Ocupada de 10 años o más de edad

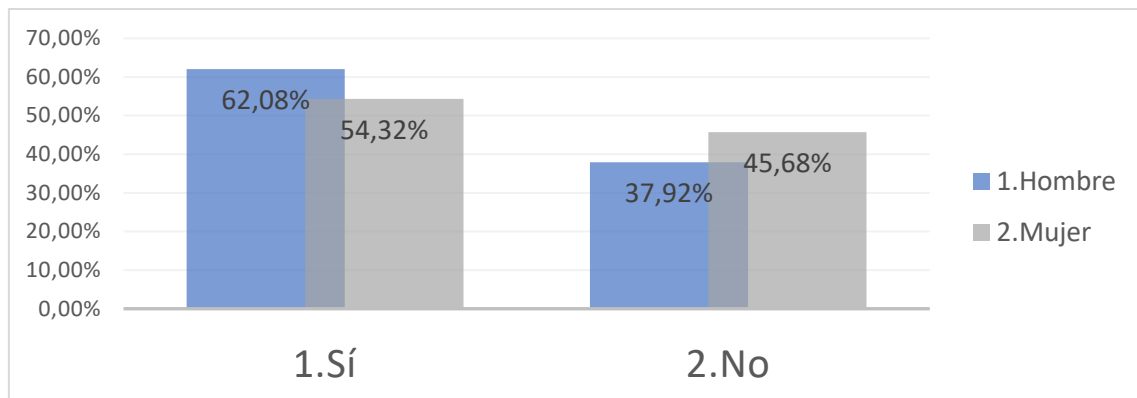
	SITUACIÓN EN EL EMPLEO			GRUPO OCUPACIONAL			
	Trabajadora/or asalariado (%)	Trabajadora/or por cuenta propia (%)	Otras categorías ocupacionales (%)	Trabajadora/or de los servicios y vendedores (%)	Trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros (%)	Trabajadores de la construcción, industria manufacturera y otros oficios (%)	Otros grupos ocupacionales (%)
Bolivia	41,5	50,6	7,9	20,4	27,2	18,1	34,3
Chuquisaca	35,5	54,2	10,3	15,2	37,8	16,6	30,4
Sucre	50,3	41,9	7,8	24,3	7,1	23,8	44,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

De la Población ocupada mayor de 10 años, el 41,9% son trabajadores por cuenta propia y el 35,5% son trabajadores asalariados. Y la mayoría trabajan en servicios o son vendedores, seguidos de los que trabajan en la construcción, industria manufacturera y otros.

2.8.1. Trabajo Juvenil

3. Jóvenes entre 16 y 28 años que trabajan



Fuente: Dirección de Juventudes GAMS Sucre en base a datos de INE 2021

De acuerdo a la Dirección de Juventudes del GAMS, en base a datos del INE, mas del 50% de las y los jóvenes trabajan, alcanzando al 62% de hombres y 54% de mujeres que realizan actividades laborales.

2.8.2. Trabajo infantil y adolescente

De acuerdo a la Encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes que realizan una actividad laboral o trabajan (ENNA 2016), se registraron 739 mil niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años (24,4%) que realizan alguna actividad laboral o trabajo, de los que:

- 238.000 realizan un trabajo prohibido es decir el 32% (Incumple con la edad mínima para trabajar, es decir son menores de 14 años; Cumple una jornada mayor a 40 horas; Realiza su actividad laboral en horarios nocturnos; Pone en riesgo sus actividades educativas)
- 154.000 realizan un trabajo peligroso es decir el 20% (por su condición o naturaleza)
- 75.000 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) entre 5 y 17 años (43.000 entre los 5 a 13 años y 31.000 entre los 14 a 17 años) trabajan en Chuquisaca:
 - 26.000 en el marco familiar
 - 38.000 ayudante de familia
 - 3.000 aprendiz
 - 7.000 por cuenta ajena
 - 1.000 por cuenta propia

Departamento	Nº de NNA Trabajadores
Chuquisaca	26.753
La Paz	97.455
Cochabamba	68.944
Potosí	29.287
Oruro	13.068
Santa Cruz	105.634
Tarija	18.534
Beni	20.564
Pando	4.088
TOTAL	384,327

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
- Censo de Población y Vivienda 2012

Ciudad	Nº de NNA Trabajadores
Sucre	9.943
La Paz	48.884
Cochabamba	37.166
Potosí	9.634
Oruro	7.095
Santa Cruz	77.543
Tarija	7.577
Trinidad	12.834
Cobija	1.455
TOTAL	212, 131

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE
- Resultados Censo de Población y Vivienda 2012

No se cuentan con datos oficiales desagregados por municipios, sin embargo, **de acuerdo al Censo 2012** 26.753 niñas, niños y adolescentes trabajaban en Chuquisaca, e los que 9.943 trabajaban en Sucre.

2.9. Cobertura educativa.

De acuerdo al EDSA 2016, aproximadamente la cuarta parte de las adolescentes de 15 a 19 años que no asiste a la escuela, da como motivo de esa inasistencia al hecho de que quedó embarazada.

En Chuquisaca se cuenta con 28 municipios, con 149.846 estudiantes matriculados (que se registró en el libro de inscripciones de una Unidad Educativa en cualquier año de escolaridad y nivel del Subsistema de Educación Regular durante una gestión escolar dada) en la gestión 2022.

Estudiantes Matriculados según Nivel de Estudio



Fuente: Ministerio de Educación 2022

de los que el 57% de estudiantes matriculados se encuentran en el municipio de Sucre, 86.127 estudiantes. El 45.1% están matriculados en el nivel de primaria, seguido del 42.4% que está matriculado en el nivel secundario y finalmente el 12,5% estudiantes de Inicial.¹²

¹² [file:///C:/Users/hp/Downloads/CHUQUISACA%20EN%20CIFRAS%202021%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/CHUQUISACA%20EN%20CIFRAS%202021%20(1).pdf)

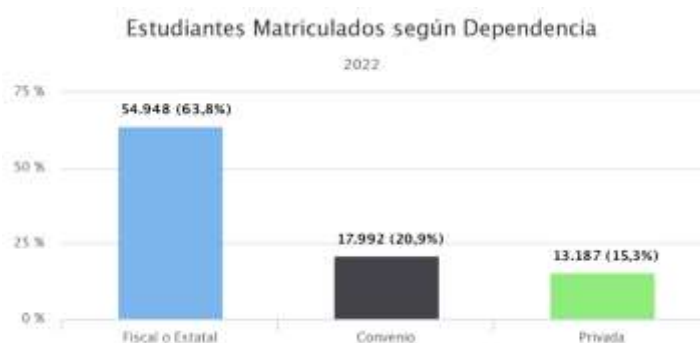
Estudiantes Matriculados según Sexo



Fuente: Ministerio de Educación 2022

De igual manera podemos identificar que el 49,4% son hombres y el 50,6% son mujeres.

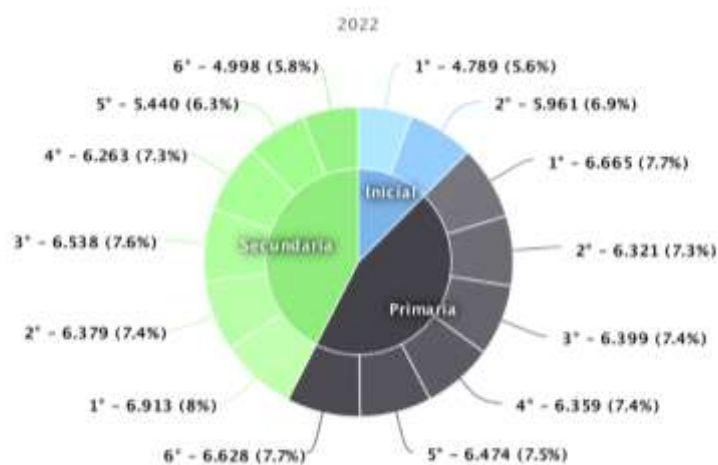
Estudiantes matriculados según dependencia



Fuente: Ministerio de Educación 2022

También notamos en el cuadro 4, que el 63,8% de los estudiantes matriculados están en colegio fiscal y estatal, el 20,9% asisten a colegios de convenio y finalmente el 15,3% de los estudiantes matriculados asisten a Unidades Educativas privadas.

Estudiantes Matriculados según nivel de Estudio y Año de Escolaridad



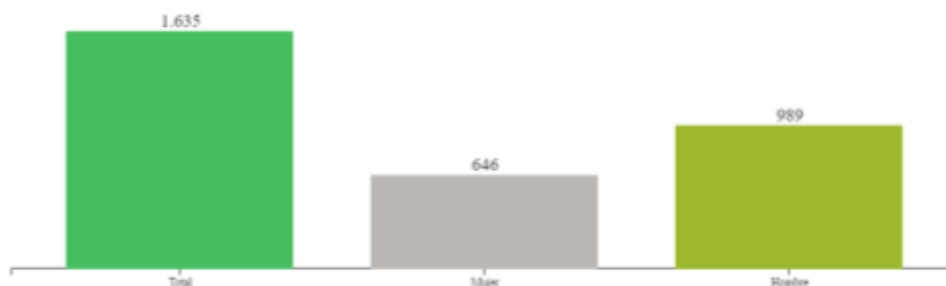
Fuente: Ministerio de Educación 2022

Es importante también conocer el nivel de estudio y año de escolaridad de los estudiantes del municipio de Sucre en la gestión 2022, donde la mayoría está cursando el nivel primario: en 1° el 7,7%; en 2° el 7,3%; en 3° el 7,4%; en 4° el 7,4%; en 5° el 7,5% y 6° con el 7,7%.

La segunda mayoría de estudiantes matriculados se encuentran en secundaria bajo el siguiente detalle: en 1° el 8%; en 2° el 7,4%; en 3° el 7,6%; en 4° el 7,3%; en 5° el 6,3% y en 6° el 5,8% de los estudiantes matriculados.

2.9.1. Tasa de abandono escolar

Estudiantes retirados por abandono en sucre, gestión 2019



Fuente: Ministerio de Educación 2019

En el municipio de Sucre, se identificó en 2019 que hubo un total de 1635 estudiantes retirados por abandono en la gestión 2019. De este número de retirados que representa el 43% de los retirados a nivel departamental, 1410 es decir el 86% es del área urbana y el 14% del área rural.

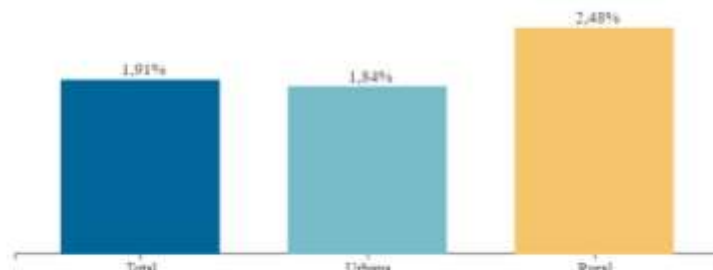
Estudiantes retirados por abandono por área geográfica

Area Geográfica	SUCRE - Todos los distritos
Total	1.635
Urbana	1.410
Rural	225

Fuente: informe de la Rendición Pública de Cuentas de la Dirección Departamental de Educación 2019

Según el informe de la Rendición Pública de Cuentas de la Dirección Departamental de Educación. la tasa de abandono escolar Departamental en el nivel inicial fue del 2.48%, en primaria 1.58%, ésta última dentro del rango nacional que en 2017 llegó al 1.6%, y de nivel secundario, 4.41%, aún por encima de la media en el país (3.8%, en 2017). Tomando en cuenta los tres niveles, el promedio es de 2.8% para la gestión 2018.

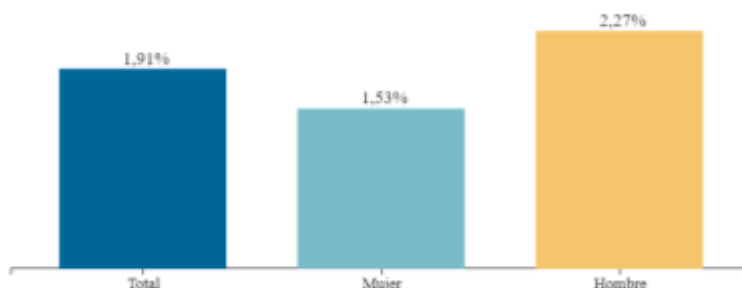
Tasa de abandono intra anual por año de escolaridad. Según: área geográfica gestión 2019



Fuente: Ministerio de Educación 2019

En relación a la tasa de abandono intra anual por año de escolaridad, en total se tiene una tasa total es de 1.91% de abandono intra anual por año del municipio de Sucre en 2019 donde 2.48% es del área rural y 1.84% del área urbana.

**Tasa de abandono intra anual por año de escolaridad.
Según: sexo gestión 2019**

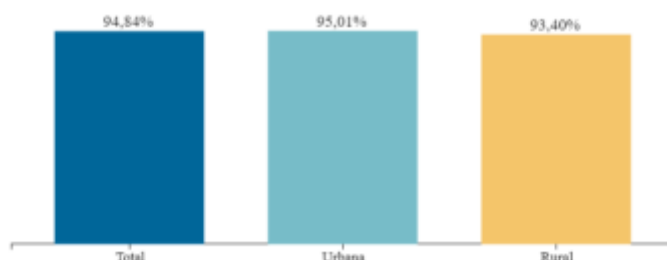


Fuente: Ministerio de Educación 2019

La tasa de abandono intra anual por año de escolaridad según sexo en el municipio de Sucre, muestra que el porcentaje en varones es mayor al alcanzar 2,27% y en el caso de las mujeres 1.53%.

2.9.2. Tasa de promoción anual

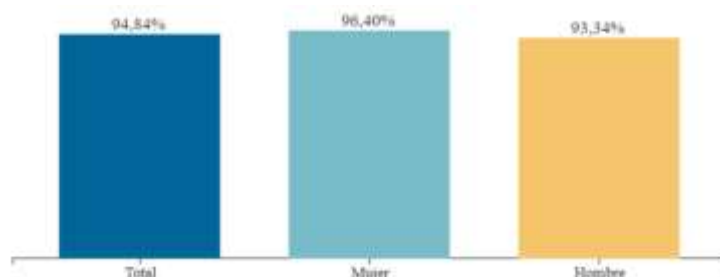
Tasa de promoción anual por zona geográfica del municipio de Sucre, 2019



Fuente: Ministerio de Educación 2019

Sobre la tasa de promoción anual por año de escolaridad según su área geográfica se identificó en 2019 (Último dato actualizado del Municipio de Sucre, brindado por el Ministerio de Educación en su página web oficial), que el 95,01% en área Urbana y 93,40% en área rural culminaron sus estudios y lograron promocionarse.

Tasa de promoción anual por zona sexo del municipio de Sucre, 2019



Fuente: Ministerio de Educación 2019

En relación a la tasa de promoción anual en el Municipio de Sucre el 96,40 de las mujeres lograron culminar y de igual manera el 93,4% de los varones.

3. Lineamientos estratégicos

3.1. Objetivo Estratégico General

Contribuir a la prevención del embarazo en adolescentes y jóvenes del Municipio de Sucre, coordinando una estrategia multisectorial con participación de adolescentes y jóvenes en el desarrollo de procesos de Educación Integral para la Sexualidad, fortaleciendo los servicios especializados de Atención Integral Diferencial para Adolescentes y Jóvenes, y el sistema de Protección Integral para una vida libre de violencias a partir de una acción conjunta entre Estado, familias y comunidad, desde un enfoque de derechos, género, generacional, intercultural e interseccional.

3.2. Lineamientos de Acciones Estratégicas

Educación Integral de la Sexualidad

- Implementar estrategias de formación y comunicación para el abordaje de la Educación Integral de la Sexualidad en el Sistema de Educación Formal, en ámbitos Comunitarios y Familiares, desde la acción participativa de las y los adolescentes y jóvenes, a través del arte en sus diferentes expresiones y medios de comunicación alternativos y tradicionales.

Atención Integral Diferenciada para Adolescentes en Salud

- Fortalecer el acceso a servicios de atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes en centros de salud fijos, móviles y virtuales, con personal especializado que brinde orientación y garantice rutas de acceso a métodos anticonceptivos modernos, promoviendo la salud sexual y reproductiva con participación de las y los adolescentes y jóvenes.

Prevención de violencia sexual a niñas y adolescentes

- Crear entornos familiares, educativos y comunitarios seguros y libres de violencia sexual, desde un enfoque preventivo, con atención oportuna para la promoción, defensa, restitución de derechos y empoderamiento de las niñas y las mujeres.

Empleo y Emprendedurismo para Adolescentes y Jóvenes

Generar oportunidades de formación técnica, empleo y emprendedurismo para adolescentes y jóvenes, con especial atención a la población en riesgo social, a madres y padres adolescentes, desde un enfoque de trabajo digno con seguridad social.

Participación y Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles

- Fortalecer el tejido de organizaciones juveniles y el Comité de prevención de embarazos en adolescentes del Consejo Municipal de la Juventud consolidando su activa participación en acciones de prevención y espacios de toma de decisión, elaboración, seguimiento, incidencia y exigibilidad de políticas públicas con enfoque de derechos, género y generacional.

Fortalecimiento Institucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

- Consolidar la articulación y coordinación intersectorial del Comité Municipal interinstitucional de políticas públicas para la juventud y los sistemas de salud, educación y protección para prevenir el embarazo en adolescentes y la violencia sexual hacia las niñas y adolescentes.

3.3. Matriz de planificación

3.3.1. Educación Integral de la Sexualidad

Lineamientos estratégicos del territorio PTDI GAM Sucre	INCREMENTAR LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y EQUIPAMIENTO EN BUENAS CONDICIONES DE MANERA PROGRESIVA PARA CONTRIBUIR A MEJORES CONDICIONES PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA E INTEGRAL.		
Pilar PGDES	3 SALUD, EDUCACION Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN DE UN SER HUMANO INTEGRAL		
EJE PDES	5. EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS		
META PDES	5.1. GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, INTERCULTURAL Y PLURILINGÜE CON CALIDAD Y SIN DISCRIMINACIÓN DE RAZA, ORIGEN, GÉNERO, CREENCIA Y DISCAPACIDAD EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL		
RESULTADO PDES	5.1.2. 5.1.2 SE HAN REDUCIDO LAS BRECHAS DE ACCESO, PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN DESVENTAJA SOCIAL O VULNERABILIDAD, PROMOVRIENDO SU INCLUSIÓN EDUCATIVA.		
ACCION PDES	5.1.2.1 Atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad e históricamente excluidas		
Indicadores PDES	Fortalecer en la curricula educativa temáticas vinculadas a la educación sexual y reproductiva, prevención del embarazo adolescente, prevención la violencia y valores para el vivir bien		
Resultado PTDI GAM Sucre	22. MEJORAR EN UN 10 % LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA EL 2025		
Acción PTDI GAM Sucre	22.1. PROMOVER UNA ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SUCRE		
LINEA DE BASE	RESULTADO (PMPEA)	ACCION (PMPEA)	INDICADOR (PMPEA)
Falta de información educación en Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos dirigida a la población en general y a adolescentes en particular, desde un enfoque preventivo.	Se han implementado estrategias de formación y comunicación para el abordaje de la Educación Integral de la Sexualidad en el Sistema de Educación Formal, en ámbitos Comunitarios y Familiares, desde la acción participativa de las y los adolescentes y jóvenes, a través	Realizar una Campaña Permanente en Educación Integral de la Sexualidad adecuada a las características generacionales y culturales de las y los adolescentes y jóvenes y la población en general en coordinación con las Subalcaldías, medios de comunicación y organizaciones de voluntariado,	N° de organizaciones y agrupaciones de adolescentes y jóvenes participan en 2 ciclos de capacitación semipresencial en EIS, y replican lo aprendido a través de la información par a par, en espacios de educación del tiempo libre, de voluntariado con actividades deportivas, culturales y ferias informativas lúdicas.

La falta de currícula especializada sobre educación sexual y reproductiva en las unidades educativas.	del arte en sus diferentes expresiones y medios de comunicación alternativos y tradicionales.	culturales y artísticas, con información verídica, oportuna, completa.	3 puntos móviles de Orientación y prevención en EIS se establecen bimensualmente en lugares estratégicos de cada distrito (mercados, paradas de micros, plazas y plazuelas más concurridas) en coordinación con juntas vecinales, organizaciones sociales y las postas de salud distritales.
			1 Campaña de Comunicación permanente se desarrolla a través de medios de comunicación, plataformas virtuales y redes sociales, en castellano y quechua con participación de adolescentes, jóvenes y entidades públicas y de sociedad civil.
		Fortalecer la Currícula regionalizada de Chuquisaca, incluyendo la EIS, desde un enfoque de derechos, despatriarcalizador, de valores para el vivir bien y de prevención de embarazo adolescente y toda forma de violencia.	N° de Gabinetes de Atención Integral a Estudiantes, en coordinación con unidades educativas y centros de salud.
			Materiales informativos, expresiones artísticas y culturales sobre EIS creadas en Concursos Anuales por los propios adolescentes y jóvenes para sensibilizar a los demás 1 biblioteca digital con materiales informativos, didácticos, lúdicos e investigativos sobre EIS se difunde

			abriendo espacios de orientación y apoyo a profesores y profesoras
			N° de unidades educativas cuentan con Planes de convivencia pacífica y armónica que han introducido la prevención del embarazo en adolescentes y la violencia sexual o contenidos sobre Educación Integral para la Sexualidad para la promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos
			N° de profesores formados y certificados en Educación Integral en Sexualidad
			N° de unidades educativas cuenta con espacios de Orientación a estudiantes y a padres y madres de familia, desde un enfoque de abordaje integral de la sexualidad y afectividad, de convivencia entre pares en igual de oportunidades, desde un enfoque de autoprotección, y desarrollo de habilidades para la vida y de proyecto de vida.

3.3.2. Atención Integral Diferenciada para Adolescentes en Salud

Lineamientos estratégicos del territorio PTDI GAM Sucre		INCREMENTAR LA COBERTURA EQUITATIVA DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD CON UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDEZ PARA LA POBLACIÓN CON EQUIDAD E INCLUSION EN EL MUNICIPIO DE SUCRE.		
Pilar PGDES		3 SALUD, EDUCACION Y DEPORTE PARA LA FORMACIÓN DE UN SER HUMANO INTEGRAL		
EJE PDES		6 SALUD Y DEPORTES PARA CUIDADO INTEGRAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA		
META PDES		6.2. FORTALECER Y UNIVERSALIZAR LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA INTERCULTURAL (SAFCI) QUE PRIORIZA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN, RECUPERANDO LA MEDICINA TRADICIONAL ANCESTRAL.		
RESULTADO PDES		6.2.1. SE HAN REDUCIDO LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES A TRAVÉS DE LA SALUD PREVENTIVA.		
ACCION PDES		6.2.1.1. Reducir el número de personas que presentan enfermedades transmisibles y no transmisibles.		
Indicadores		Embarazo en Adolescentes		
Resultado PTDI GAM Sucre		3. INCREMENTAR DEL 65,61% AL 100% LA TASA DE ACCESO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA EL 2025		
Acción PTDI GAM Sucre		3.1. MANTENER AL 100% SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL PARA LA CONTENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA EL 2025		
LINEA DE BASE		RESULTADO (PMPEA)	ACCION (PMPEA)	INDICADOR (PMPEA)
De los 574 embarazos en adolescentes que se registraron en Sucre: 557 fueron embarazos en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años edad (97%). 17 embarazos fueron en niñas y adolescentes		Se ha fortalecido el acceso a servicios de atención integral diferenciada para adolescentes y jóvenes en centros de salud fijos, móviles y virtuales, con personal especializado que brinde orientación y garantice rutas de acceso a métodos anticonceptivos modernos,	Implementar consultorios especializados en la atención diferenciada a adolescentes y jóvenes en los centros de salud y postas sanitarias de administración del GAM Sucre mediante la Certificación de Centros de salud AIDA	N° de servidores públicos de salud capacitado y sensibilizado en AIDAJ.
				N° de estrategias de difusión a adolescentes en particular, y a la población en general de los Centros AIDAJ
				N° de protocolos de salud actualizados desde un enfoque de AIDAJ
				Al menos 2 consultorios móviles especializados en atención diferencia a adolescentes y jóvenes, compuestos por equipos multidisciplinarios,

menores de 15 años en edad (3%).	promoviendo la salud sexual y reproductiva con participación de las y los adolescentes y jóvenes.		brindan atención y orientación para adolescentes y consejería para padres y madres de familia
			N° de Centros de Salud de 1er y 2do nivel con Certificación AIDAJ otorgada cuenta con mecanismo de seguimiento en coordinación con las juventudes de organizaciones y agrupaciones juveniles
		Ampliar y fortalecer los servicios de orientación y prevención del embarazo adolescente, mejorando las rutas de acceso hacia métodos anticonceptivos modernos con participación de los jóvenes y adolescentes.	N° de Campañas de información sobre métodos anticonceptivos realizadas por medios de comunicación, redes sociales y en Unidades Educativas
			N° de campañas de acceso gratuito y/o a bajo costo a consultas ginecológicas y de urología gratuitas con personal especializado a métodos anticonceptivos intrauterinos, métodos anticonceptivos hormonales y a anticoncepción de emergencia.
			Al menos 2 servicios de atención virtuales en funcionamiento con la creación de una app de información e interacción para adolescentes y un servicio de orientación a través de telemedicina en salud sexual y reproductiva
		Brindar atención medica de emergencia en casos de violencia sexual aplicando la Sentencia Constitucional 0206/2014	N° de servidores públicos del área de salud y de defensorías de la niñez y adolescencia con formación permanente sobre medidas de atención de emergencia y la SC 0206/2014
			N° de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual reciben el apoyo y la información oportuna y pertinente en la atención de

			emergencia con acceso a anticoncepción de emergencia, ILE, de acuerdo al caso. 1 campaña permanente de sensibilización sobre las causales para la ILE y sobre la SC 0206/2014 realizada en medios de comunicación y redes sociales N° de ILEs realizadas en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, o en riesgo en relación a su vida y salud con la debida atención médica y con la oportuna orientación, contención emocional y apoyo psicológico pertinentes.
--	--	--	--

3.3.3. Prevención de violencia sexual a niñas y adolescentes

Lineamientos estratégicos del territorio PTDI GAM Sucre	REDUCIR DE MANERA PROGRESIVA LAS BRECHAS Y BARRERAS DE GÉNERO Y AVANZAR HACIA MAYORES NIVELES DE JUSTICIA SIN DESIGUALDADES DE CLASE, ETNIA, GÉNERO, GENERACIONAL, CAPACIDADES DIFERENTES Y OTRAS FORMAS DE DESIGUALDAD.
Pilar PGDES	11. SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL NO ROBAR, NO MENTIR Y NO SER FLOJO
EJE PDES	7. REFORMA JUDICIAL, GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE Y SEGURIDAD Y DEFENSA CON SOBERANÍA NACIONAL
META PDES	7.3. Erradicar todas las formas de violencia por razones económicas, sociales y culturales, con énfasis en la violencia en razón de género en sus distintas manifestaciones y la lucha contra la trata y tráfico de personas
RESULTADO PDES	7.3.2 SE HA LUCHADO CONTRA TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER
ACCION PDES	7.3.1.3. Implementar medidas integrales y efectivas de lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes (FELCV, SLIMS, Defensorías, Ministerio público, IDIF).
Indicador PDES	Mujeres en situación de violencia de pareja que solicitaron ayuda a alguna institución y presentaron denuncia formal
Resultado PTDI GAM Sucre	25. REDUCIR EN 10 % LOS INDICES DE VIOLENCIA A TRAVES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA A LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA EL 2025

Acción PTDI GAM Sucre	25.1. FORTALECER EL 100% LA ATENCIÓN CON SERVICIO DE PREVENCIÓN, AUXILIO E INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA 2023		
LINEA DE BASE	RESULTADO (PMPEA)	ACCION (PMPEA)	INDICADOR (PMPEA)
De acuerdo a los datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, se identifican 4 tipos de violencia sexual que se producen con mayor frecuencia: 227 casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años (154 son delitos de violación a niña, niño y adolescente, 73 son delitos de Estupro)	Se han creado entornos familiares, educativos y comunitarios seguros y libres de violencia sexual, desde un enfoque preventivo, con atención oportuna para la promoción, defensa, restitución de derechos y empoderamiento de las niñas y las mujeres	Elaborar e implementar un programa interinstitucional de prevención contra toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes	Implementar campañas masivas especializadas de socialización de las tipologías de violencia establecidas en la ley 348 y la ley 548, utilizando medios de comunicación e información adecuados para llegar a adolescentes y su entorno, madres, padres o tutores, profesores y personal de salud.
			Contextualizar y difundir una ruta de atención municipal para la atención y sanción contra toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes
			Brindar formación permanente para la atención y prevención de violencia Sexual y para la aplicación del protocolo nacional de prevención, atención y sanción contra toda forma de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes
			Seguimiento a la aplicación de la Ruta de Violencia Sexual en coordinación con la DNNA y SLIM de cada distrito del municipio.
			Nº de servidores públicos con formación permanente sobre atención especializada a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual

			Al menos 4 equipos interdisciplinario aplican Ciclos de formación integral sobre noviazgos violentos en base a cartillas con contenidos amigables (Tips para reconocer situaciones violentas/ Ciclo de la violencia en el noviazgo/Orientación para prevenir noviazgos violentos) con diferentes grupos de adolescentes y jóvenes, realizando el seguimiento a la réplica en cascada
			Al menos 1 equipo de mecanismos de justicia restaurativa se conforma en coordinación entre SEDEGES y OSC para trabajar con los adolescentes con responsabilidad penal que cometieron delitos de violencia sexual (proyecto personal, relaciones interpersonales sanas y servicios comunitarios como parte de las medidas de reintegración social) con atención especializada para las víctimas desde un enfoque de protección y no revictimización para la reparación integral del daño.

3.3.4. Empleo y Emprendedurismo para Adolescentes y Jóvenes

Lineamientos estratégicos del territorio PTDI GAM Sucre		Transversal		
Pilar PGDES	5. SOBERANÍA COMUNITARIA FINANCIERA			
EJE PDES	1 RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL			
META PDES	1.3. Devolver a la política social el carácter prioritario para el Estado, reduciendo la desigualdad económica, social y de género en el marco de la pluralidad. 1.4. Implementar programas de empleo directo e indirecto y diseñar mecanismos que promuevan el empleo formal y reduzcan las brechas de género en el empleo.			
RESULTADO PDES	1.4.1 SE HAN PROMOVIDO PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS HOGARES A TRAVÉS DE LA GENERACÓN DE EMPLEO PRIORIZANDO SECTORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y DISMINUCIÓN DEL SUBEMPLEO			
ACCION PDES	1.4.1.1 Programas de generación de empleos a nivel nacional			
Indicadores PDES	Número de inserciones laborales con énfasis en mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Número de beneficiarios del Programa de Empleo Digno para la juventud. Número de beneficiarios del Programa de pasantías masivas en el sector público para jóvenes del nivel técnico y profesional.			
Resultado PTDI GAM Sucre	29. MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA EL 2025			
Acción PTDI GAM Sucre	29.1. FORTALECER UN PROGRAMA PARA PROMOVER CAPACIDADES EN GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ATRAVEZ DE LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADA DEL MUNICIPIO DE SUCRE			
LINEA DE BASE		RESULTADO (PMPEA)	ACCION (PMPEA)	INDICADOR (PMPEA)
De acuerdo a la ETA – INE 75.000 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) entre 5 y 17 años (43.000 entre los 5 a 13 años y 31.000 entre los 14 a 17 años) trabajan en Chuquisaca:		Se han generado oportunidades de formación técnica, empleo y emprendedurismo para adolescentes y jóvenes, con especial atención a la población en riesgo social, a madres y padres adolescentes, desde un enfoque	Implementar programas de formación técnica y fomento a la empleabilidad y emprendedurismo a la cabeza del Centro de Empleo Juvenil CEJ	Nº de convenios interinstitucionales suscritos con institutos técnicos públicos y privados y Organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro que brinden formación técnica acordando cupos para adolescentes y jóvenes en situación de

○ 26.000 en el marco familiar ○ 38.000 ayudante de familia ○ 3.000 aprendiz ○ 7.000 por cuenta ajena ○ 1.000 por cuenta propia No se cuentan con datos oficiales desagregados por municipios, sin embargo, de acuerdo al Censo 2012 26.753 niñas, niños y adolescentes trabajaban en Chuquisaca, e los que 9.943 trabajaban en Sucre.	de trabajo digno con seguridad social		vulnerabilidad y madres y padres adolescentes Nº de convenios suscritos para el acceso directo a carreras técnicas y universitarias para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y madres y padres adolescentes Nº de convenios intergubernativos establecidos para que adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y madres y padres adolescentes puedan acceder a programas de empleabilidad (Programa de apoyo al empleo) dirigidos por el nivel central o departamental 1 sistema de información de registro y autorización de trabajo de niñez y adolescencia se implementa desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Nº de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y madres y padres adolescentes acceden a programas de emprendedurismo o capital semilla para emprendimientos individuales y colectivos organizados por el CEJ % de participación de adolescentes en situación de trabajo y jóvenes en todos los proyectos de desarrollo
--	--	--	---

			económico productivo del Gobierno Municipal de Sucre y otras entidades públicas y privadas
--	--	--	--

3.3.5. Participación y Fortalecimiento de Organizaciones Juveniles

Lineamientos estratégicos del territorio PTDI GAM Sucre	REDUCIR DE MANERA PROGRESIVA LAS BRECHAS Y BARRERAS DE GÉNERO Y AVANZAR HACIA MAYORES NIVELES DE JUSTICIA SIN DESIGUALDADES DE CLASE, ETNIA, GENERO, GENERACIONAL, CAPACIDADES DIFERENTES Y OTRAS FORMAS DE DESIGUALDAD.		
Pilar PGDES	11. SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL NO ROBAR, NO MENTIR Y NO SER FLOJO		
EJE PDES	7. REFORMA JUDICIAL, GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE Y SEGURIDAD Y DEFENSA CON SOBERANÍA NACIONAL		
META PDES	7.2. FORTALECER PROGRAMAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES CON ÉNFASIS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL		
RESULTADO PDES	7.2.2. SE HAN ATENDIDO LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE Y SU INCLUSIÓN SOCIAL EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ENFOQUE DE GÉNERO.		
ACCION PDES	7.2.2.2 Promoción y defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, priorizando zonas rurales y comunidades alejadas y énfasis en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres con discapacidad.		
Indicador	Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas con promoción de sus derechos		
Resultado PTDI Sucre	24. FORTALECER EN EL 100% LAS ATENCIONES DE LOS GRUPOS DE POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE INCLUSIVO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA LA GESTION 2025		
Acción PTDI Sucre	24.2. INCREMENTAR DE 6.629 A 53.562 LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE INCLUSIVO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA EL 2025		
LINEA DE BASE	RESULTADO (PMPEA)	ACCION (PMPEA)	INDICADOR (PMPEA)
De acuerdo a las proyecciones poblacionales - revisión 2020, UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de las niñas, niños,	Se ha fortalecido el tejido de organizaciones y agrupaciones juveniles y el Comité de prevención de embarazos en adolescentes del Consejo	Fortalecer al Comité de prevención de embarazos en adolescentes del Consejo Municipal de la Juventud y el Comité Municipal de la niñez y adolescencia, promoviendo su activa	Nº de cursos y talleres de formación en Educación Integral para la sexualidad, marco normativo y de políticas públicas y estándares internacionales de derechos sexuales

adolescentes y jóvenes menores de 19 años de Sucre que son el 38% de la población de Sucre: • El 24% son niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años (33.019) • Y el 27,2% son adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años (37.403). (UNFPA en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, proyecciones poblacionales - revisión 2020)	Municipal de la Juventud consolidando su activa participación en acciones de prevención y espacios de toma de decisión, elaboración, seguimiento, incidencia y exigibilidad de políticas públicas con enfoque de derechos, género y generacional.	participación en acciones de incidencia en políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos y en el seguimiento a la implementación del Plan de prevención de embarazo en adolescentes del Municipio de Sucre	y reproductivos y de lucha contra la violencia sexual dirigidos realizados con los miembros del Consejo Municipal de la Juventud y el Comité Municipal de niñez y adolescencia Nº de actividades de implementación y seguimiento del Plan de prevención de embarazo en adolescentes del Municipio de Sucre realizadas por el Comité de prevención de embarazos en adolescentes del Consejo Municipal de la Juventud y el Comité Municipal de Niñez y Adolescencia que cuenta con apoyo técnico y logístico permanente Nº de eventos y acciones de fortalecimiento de organizaciones y agrupaciones juveniles comprometidas con la Educación Integral para la Sexualidad y la Salud Sexual y Reproductiva realizadas por el Comité de prevención de embarazos en adolescentes del Consejo Municipal de la Juventud y el Comité Municipal de la Niñez y adolescencia que cuenta con apoyo técnico y logístico permanente Informes económicos del Presupuesto, infraestructura, equipamiento y apoyo técnico brindado para las actividades de
---	--	---	--

			prevención de embarazo en adolescentes y prevención de violencia sexual desarrollados bajo la coordinación y liderazgo del Consejo Municipal de la Juventud y el Comité Municipal de Niñez y Adolescencia de Sucre
			N° de estrategias de seguimiento a la aplicación práctica de conocimientos de servidores públicos, profesores y educadores, implementadas por las organizaciones y agrupaciones juveniles.
			Nª de espacios generados por el Consejo municipal de la juventud de Sucre, para establecer encuentros, audiencias o reuniones entre organizaciones y agrupaciones juveniles y las autoridades ejecutivas y legislativas del municipio sobre temas relacionados al Plan de prevención de embarazo en adolescentes del Municipio de Sucre

3.3.6. Fortalecimiento Institucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes

Lineamientos estratégicos del territorio PTDI GAM Sucre	REDUCIR DE MANERA PROGRESIVA LAS BRECHAS Y BARRERAS DE GÉNERO Y AVANZAR HACIA MAYORES NIVELES DE JUSTICIA SIN DESIGUALDADES DE CLASE, ETNIA, GÉNERO, GENERACIONAL, CAPACIDADES DIFERENTES Y OTRAS FORMAS DE DESIGUALDAD.		
Pilar PGDES	11. SOBERANÍA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA BAJO LOS PRINCIPIOS DEL NO ROBAR, NO MENTIR Y NO SER FLOJO		
EJE PDES	7. REFORMA JUDICIAL, GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE Y SEGURIDAD Y DEFENSA CON SOBERANÍA NACIONAL		
META PDES	7.2. FORTALECER PROGRAMAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL PARA LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES CON ÉNFASIS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL		
RESULTADO PDES	7.2.2. SE HAN ATENDIDO LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE Y SU INCLUSIÓN SOCIAL EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CON ENFOQUE DE GÉNERO.		
ACCION PDES	7.2.2.2 Promoción y defensa de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, priorizando zonas rurales y comunidades alejadas y énfasis en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres con discapacidad.		
Indicadores PDES	Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas con promoción de sus derechos.		
Resultado PTDI Sucre	24. FORTALECER EN EL 100% LAS ATENCIONES DE LOS GRUPOS DE POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CON ENFOQUE INCLUSIVO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA LA GESTION 2025		
Acción PTDI Sucre	24.2. INCREMENTAR DE 6.629 A 53.562 LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON ENFOQUE INCLUSIVO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE HASTA EL 2025		
LINEA DE BASE	RESULTADO (PMPEA)	ACCION (PMPEA)	INDICADOR (PMPEA)
Comité Municipal interinstitucional de políticas públicas para la juventud conformado y en funcionamiento bajo el liderazgo de la Dirección Municipal de Juventudes	Consolidar la articulación y coordinación intersectorial del Comité Municipal interinstitucional de políticas públicas para la juventud y los sistemas de salud, educación y protección para prevenir el embarazo en adolescentes y la	Definir la inserción de partidas dentro del poa de las unidades de prevención, familia y la dirección de juventudes del GAM Sucre, para la implementación del Plan de prevención del embarazo adolescente del municipio de Sucre y acciones concretas de competencia normativa como la incorporación en el	Nº de sesiones del Comité Municipal interinstitucional de políticas públicas para la juventud en las que se aborda el establecimiento de Agenda de coordinación interinstitucional y el seguimiento del Plan de prevención del embarazo adolescente del municipio de Sucre

	violencia sexual hacia las niñas y adolescentes.	POA municipal recursos para la aplicación de la SCP 206/2014	Nº de cursos, talleres y procesos de formación realizados a través de una plataforma digital de formación para la actualización de profesionales que realizan atención directa a adolescentes y jóvenes en temas como atención diferenciada, salud sexual y salud reproductiva, prevención de violencia, etc. Estrategia de institucionalización del personal que realiza atención directa a adolescentes (DNAs, servicios de orientación) diseñada e implementada de acuerdo a lo establecido en el Código niña, niño y adolescente, las leyes municipales 120 y 047, que definen que el personal de atención a adolescentes y jóvenes debe ser especializado. Sistema de información para el reporte del Índice de embarazo en adolescente diseñado y en funcionamiento Estrategia de seguimiento a la formación de servidores públicos, profesores y educadores Estrategia de seguimiento y monitoreo de normativas y políticas públicas a través de indicadores relacionados a la Educación Integral
--	---	---	---

			para la sexualidad y un sistema de reporte diseñada e implementada
			Comité de prevención de embarazo en adolescentes del Consejo Municipal de la juventud Fortalecido con apoyo técnico permanente
			Agenda de coordinación interinstitucional para la implementación del Plan de prevención de embarazo en adolescentes por parte del Comité Municipal Interinstitucional de Políticas Públicas de la Juventud aprobada y en implementación permanente

4. Actores estratégicos

Entre los actores identificados para la ejecución del Plan de prevención de embarazo en adolescentes del Municipio de Sucre, se encuentran tanto Organizaciones y Agrupaciones Juveniles como Instituciones Públicas y Organizaciones de Sociedad Civil (ONGs y fundaciones).

Las instituciones que trabajan en el área de educación, en relación a la promoción, difusión sensibilización para la Educación Integral en Sexualidad, son la Dirección Distrital y Departamental de Educación, Prevención del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, etc. de temas relacionados a la prevención del embarazo y los derechos sexuales y reproductivos podemos nombrar a CIES, Marie Stopes, CEMSE, Aldeas Infantiles SOS, CONBOJUV, CEADL, ONG Realidades, Centro Juana Azurduy CETA, MANQA, Escuela Taller Sucre, Fe y Alegría, Fundación Equilibrio y otras.

Para el área de atención en salud, atención psicológica, atención integral, entre otras, podemos señalar a SEDES, DIMUSA, CIES, Marie Stopes, CEMSE, Centro Juana Azurduy y otras.

En relación al área económico productivo, se puede coordinar con la Secretaria de Desarrollo Productivo, la Dirección Municipal de Juventudes, los institutos técnicos existentes en Sucre de los que podemos nombramos algunos como: ITSEC, Fe y Alegría, CCA, INFOCAL, ITEC, CETA, Escuela Taller Sucre, MANQA y otras.

Para la atención de la violencia en razón de género y las acciones dirigidas a la prevención podemos señalar como posibles aliados a DNA, SLIM, Género, Familia, SEDEGES y entidades OSC como CIES, Marie Stopes, CEMSE, CONBOJUV, CEADL, ONG Realidades, Centro Juana Azurduy y otras.

Es importante señalar la existencia de redes interinstitucionales existentes a nivel municipal como La Red del Observatorio de derechos, la Red de Lucha contra la violencia, la Plataforma por el acceso a la Justicia, el Capítulo Boliviano de Derechos, así como instancias de coordinación interinstitucional de alcance departamental como el Sub consejo departamental de coordinación sectorial e intersectorial para temas de la niña niño y adolescente, el Consejo Departamental de lucha contra la trata y tráfico de personas de Chuquisaca, la Plataforma Interinstitucional de prevención de embarazo en Adolescentes, que se constituyen en aliados estratégicos, para la implementación de este plan.

5. Seguimiento y monitoreo

El Plan de prevención de embarazo en adolescentes del Municipio de Sucre adoptará un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación participativo bajo la coordinación de la Dirección Municipal de Juventudes, el Consejo Municipal de la Juventud y el Comité Interinstitucional de Políticas Públicas para la juventud.

El mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación participativo del plan permitirá determinar el progreso de las actividades y tomar las medidas necesarias de manera conjunta para resolver los problemas y realizar los ajustes necesarios en las actividades estratégicas a través del seguimiento al cumplimiento de los indicadores.

Metodológicamente, se realizará un seguimiento sistemático de la consecución de indicadores de proceso mediante estrategias predictivas y propositivas, estableciéndose como el principal

espacio de retroalimentación para los ajustes sesiones semestrales donde participaran tanto el Consejo Municipal de la Juventud como el Comité Interinstitucional de Políticas Públicas para la juventud, y el Comité Municipal de Niñez y Adolescencia, en los que se considerará el análisis cualitativo de logros intermedios, que a su vez permitirán que el equipo técnico y ejecutivo de la Dirección Municipal de Juventudes puedan medir la eficiencia de los procesos y eficacia de las operaciones, con características propositivas que posibiliten ajustes.

Coordinando con el Comité de prevención de embarazo en adolescentes, la generación de informes Anuales de Avance.

Anexos

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Proceso participativo de elaboración del Plan Municipal

RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo ha elaborado diferentes recomendaciones defensoriales que se han tomado en cuenta al diseñar la planificación del presente plan de prevención de embarazos en adolescentes y que el Gobierno Municipal de Sucre debe tomar en cuenta de manera transversal al implementar el mismo:

En el Informe defensorial “Las Niñas, Niños y Adolescentes Derechos Invisibilizados y Vulnerados” refiere que el embarazo en adolescentes es una problemática que atenta contra el derecho a la vida, porque de acuerdo al Banco Mundial y UNFPA, las adolescentes entre las edades de 15 a 19 años, tiene dos veces mas probabilidades de morir durante el embarazo o parto que aquellas mayores de 20 años, y las menores de 15 años tienen cinco veces mas probabilidades de falleres.

Y recomienda crear el sistema de atención diferenciada y especializada para adolescentes en todo el sistema de salud e invertir en programas de prevención de la violencia sexual y el embarazo precoz.

El informe defensorial “Situación de la interrupción legal del embarazo como derecho humano de las mujeres” describe que, de acuerdo con el Estudio nacional de Mortalidad Materna, realizado por el Ministerio de Salud, es la tercera causa de muerte en mujeres gestantes, y entre las causas directas de muerte materna el 59% es por hemorragia, 19% por hipertensión, 13% por aborto, 7% por infecciones y 2% por parto prolongado.

Así mismo, refiere que existe una falta de garantías para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que existe un incumplimiento del procedimiento técnico para la atención de la ILE, que vulnera el derecho a vivir una vida libre de violencia y una ausencia de capacidades de los gobiernos departamentales y municipales para la atención de la ILE y registro en los establecimientos de salud. Destacando que en el POA del SLIM no se asignan recursos específicos para atención de casos referentes a la Sentencia Constitucional 206/2014 y que la atención se realiza con las cajas con donaciones y la atención cubierta con el SUS.

Sin embargo, el informe defensorial describe que se reporta que se capacito al personal del municipio y SEDES en diferentes oportunidades sobre el modelo de atención a victimas de violencia y la SC 206/2014.

Y finalmente se recomienda incluir en los POA, recursos de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los servicios de salud para el cumplimiento del procedimiento técnico; Además de garantizar la infraestructura, equipamiento, medicamento e insumos suficientes y adecuados para la atención integral de la interrupción legal y segura del embarazo y la anticoncepción post aborto; Y capacitar y actualizar permanentemente al recurso humano en la tecnología basada en la evidencia científica para la ILE, así como en las normas, protocolos y procesos específicos de ILE.

El informe defensorial sobre el “Incumplimiento del artículo 23 del Código Niña, Niño y Adolescente. Acciones para la prevención del embarazo en adolescentes” describe que el 100% de las ETAS al no conocer sobre el índice de embarazo adolescente nacional y en sus jurisdicciones no han programado la realización de acciones diferenciadas y reasignaciones presupuestarias, en el marco del mandato legal sobre prevención del embarazo adolescente.

Recomendando que los Gobiernos Municipales que superen el índice de embarazo adolescente que deben implementar programas bajo la coordinación intersectorial e interinstitucional

porque la problemática del embarazo en adolescentes es una problemática compleja multicausal y multifacética, por lo que la mejor manera de responder al mismo es a través de acciones de carácter integral y multinivel, desarrollando un monitoreo y seguimiento permanentes y cuando corresponda desarrollar acciones diferenciadas para su disminución.

PROCESO DE ELABORACIÓN PARTICIPATIVO

La elaboración del Plan Municipal de Prevención de Embarazo Adolescente PEA en el municipio de Sucre, se ha desarrollado a través de un proceso participativo amplio a la cabeza de la Dirección Municipal de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Consejo Municipal de la Juventud de Sucre, en coordinación con el Comité Municipal Interinstitucional para Políticas Públicas, contando con la participación en diferentes espacios con actores de instituciones públicas, instituciones de sociedad civil y organizaciones y agrupaciones de jóvenes.

La **Metodología participativa**, conto con varias fases de recogida de propuestas y validación de la información obtenida, las fases se detallan a continuación:

- **Fase de coordinación y organización:** el proceso inicio con la elaboración del Plan de trabajo, donde se definió la Metodología y el Cronograma de actividades, que fueron consensuados en reuniones técnicas con la Dirección Municipal de la Juventud – GAM Sucre y el Consejo Municipal de la Juventud de Sucre, que se realizaron el 26 de julio de 2022 con la Dirección Municipal de la Juventud – GAM Sucre y el 02 de agosto de 2022 con el Consejo Municipal de la Juventud de Sucre, en las que se presentó y se ajustaron la metodología y el cronograma de trabajo, estas reuniones técnicas además realizar el planteamiento de la metodología se identificó a los actores estratégicos y se diseñaron las herramientas de recojo de propuestas, que posteriormente se compartieron y fueron ampliamente difundidas a través de Cartas dirigidas a Organizaciones Juveniles, Entidades Públicas y de Sociedad Civil.

El día 03 de agosto de 2022 por medio de una **conferencia de prensa**, se realizó el lanzamiento público de la Agenda para Recogida de Propuestas, esta conferencia se realizó en instalaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en el Ex Hotel Municipal, con la presencia de representantes de la Dirección Municipal de la Juventud – GAM Sucre, el Vicepresidente del Consejo Municipal de la Juventud de Sucre y un representante de UNFPA.

- **Fase de recojo de propuestas:** esta fase inicio con el lanzamiento público de Recogida de Propuestas y se realizó mediante los siguientes eventos y herramientas participativas:
 - **Recojo de propuestas de Instituciones: Sesión del Comité Municipal Interinstitucional de Políticas Públicas de la Juventud** realizada el 17 de agosto de 2022. Donde los representantes de las entidades miembros del comité interinstitucional realizaron sus propuestas en un espacio de dialogo participativo, en el evento se contó con la participación de las siguientes instituciones tanto públicas como privadas:
 - Entidades públicas y academia
 - Dirección Municipal de la Juventud – GAM Sucre
 - Consejo Municipal de la Juventud de Sucre
 - Comité Municipal Interinstitucional de Políticas Públicas de la Juventud

- Servicio departamental de Salud
- Dirección Distrital de Educación
- Dirección Departamental de Educación
- Defensorías de Niñez y Adolescencia – GAM Sucre
- Género – GAM Sucre
- SLIM – GAM Sucre
- Gestión Social – GAM Sucre
- Jefatura de Gestión Educativa – GAM Sucre
- INE
- Jefatura Departamental de Trabajo
- GACIP
- Universidad del Valle - UNIVALLE
- Escuela Superior de Formación Mariscal Sucre
- SENASAG
- Organismos internacionales, entidades, organizaciones no gubernamentales y Redes Estratégicas
 - UNFPA
 - Cainco
 - Promotoras comunitarias Observatorio de Derechos
 - CIES
 - Marie Stopes
 - Combojuv
 - ONG Realidades
 - CEMSE
 - IPTK
 - Centro Juana Azurduy
 - Fundación Tréveris
 - CEADL
 - Plataforma de Investigación y Formación Especializada - PIFE
- **Recojo de propuestas de organizaciones juveniles: Reunión del Consejo Municipal de la Juventud de Sucre y organizaciones juveniles y de niñez y adolescencia** realizada el 23 de agosto de 2022. En la que participaron representantes de las siguientes organizaciones Juveniles:
 - Consejo Municipal de la Juventud de Sucre
 - Comité Municipal de Niñez y Adolescencia de Sucre
 - Tú decides
 - Plataforma departamental de prevención de embarazo adolescente
 - Sociedad Científica de Estudiante de Derechos – Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
 - Grupo Scout Junín
 - Redbol
 - LB Sayariy
 - Comisión de Juventudes – Observatorio de Derechos
- **Buzón digital** (Formulario On line), por correo electrónico o entrevista:
 - Comité de Niñez y Adolescencia de Sucre

- Delegación presidencial para el Bicentenario
 - Observatorio de Derechos
 - Centro Juana Azurduy
 - ONG Realidades
 - CIES
 - CEADL
 - Aldeas SOS
 - Consorcio Boliviano de Juventudes
- **Audiencia Pública** de recogida de propuestas retransmitida por Facebook Live realizada el 26 de agosto de 2022. En la que participaron el Director de Juventudes del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Vicepresidente del Consejo Municipal de la Juventud, recibiendo las propuestas presentadas por las siguientes entidades:
 - Observatorio de Derechos
 - ONG Realidades
 - CIES
- También se recogieron propuestas de actores clave a través de las siguientes estrategias:
 - **Solicitud de Información** escrita a actores estatales: Notas de Recojo de Información a Actores Estratégicos.
 - **Entrevistas individuales** con Actores Estratégicos como la Dirección Departamental de Educación, el Servicio Departamental de Salud, la Defensoría del Pueblo, Aldeas SOS, COMBOJUV, Promotoras Comunitarias, ONG Realidades.
- **Fase de sistematización de propuestas:** Posteriormente a la recogida de propuestas se desarrolló un trabajo de gabinete por parte de la consultora de UNFPA Tahí Abrego, para sistematizar todas las propuestas recibidas en el formato de las matrices acordes al PTDI, además de elaborar el diagnóstico en base a los datos oficiales y el marco normativo internacional y nacional del documento **del Plan Municipal de Prevención de Embarazo Adolescente PEA en el municipio de Sucre**, que fue presentado para su validación por parte del Comité Municipal Interinstitucional de Políticas Públicas de la Juventud, del Consejo Municipal de la Juventud y las instituciones que realizaron sus propuestas para el plan.
- **Validación:** La validación del Plan Municipal de Prevención de Embarazo Adolescente PEA en el municipio de Sucre, se realizó el día 15 de septiembre de 2022 en un evento convocado por la dirección Municipal de Juventudes, en este evento participaron las instituciones y organizaciones que realizaron propuestas para el Plan.

Luego de haber realizado la sistematización de las propuestas recogidas en los diferentes eventos realizados con instituciones de sociedad civil, organizaciones y agrupaciones juveniles y de voluntariado, además de una audiencia pública, a la cabeza de la Dirección Municipal de Juventudes del GAM Sucre y el Consejo Municipal de la Juventud de Sucre, así como también la recepción de las propuestas presentadas a través del formulario online.

El día jueves 15 de septiembre de 2022, se llevó a cabo el evento de validación del “Plan de prevención de embarazos en adolescentes en el municipio de Sucre”, donde se contó con la participación de los actores que participaron de los eventos y presentaron propuestas, contando con la presencia de representantes de las siguientes instituciones:

- Unidad de Familia - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- DNAs - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- SLIMs - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- Dirección de Juventudes Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- Unidad de Género - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- Dirección de Desarrollo Social - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- Jefatura de gestión educativa - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- Jefatura de salud - Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- Jefatura de gestión educativa y juventudes - Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
- SEDEGES Chuquisaca
- CEPAT - Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
- Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca
- Dirección Distrital de Educación de Sucre
- Escuela de formación superior de maestros
- Instituto Nacional de Estadística
- Promotoras comunitarias
- Consejo Municipal de la Juventud de Sucre
- UNFPA
- Centro Juana Azurduy
- Observatorio de Derechos,
- Descúbrete
- Plataforma de Investigación y Formación especializada
- ONG Realidades
- CIES
- Fundación Sinp’arispá
- Jóvenes de los distritos 2 y 5 del municipio de Sucre

El evento inicio con las palabras del Director de Juventudes del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Lic. Jonathan G. Ramírez, para dar paso a la presentación realizada por la consultora de UNFPA Tahí Abrego, que informo que con el apoyo técnico y financiero de UNFPA desde la Dirección de Juventudes se desarrolló un proceso participativo de elaboración del “Plan de prevención del embarazo en adolescentes”, pasando a presentar el documento borrador del mismo para su validación por los presentes.

En este marco, se realizó una presentación del documento y posteriormente se realizó un trabajo de mesas, donde se realizó la revisión en detalle de las matrices del “Plan de prevención de embarazo en adolescentes”, donde tomaron nota de los aportes que realizaron los participantes al plan. El evento cerro con la recogida de las propuestas realizadas en las matrices.

Finalmente se incluyeron las ultimas sugerencias que realizaron las instituciones, al documento final del Plan Municipal de Prevención de Embarazo Adolescente PEA en el municipio de Sucre.

Después del evento de validación, se realizó una **reunión de análisis de la compatibilización del Plan Municipal de Prevención de Embarazo Adolescente PEA en el municipio de Sucre y el Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno Municipal de Sucre**. La reunión se realizó el viernes 16 de septiembre entre la Dirección Municipal de Juventudes, la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y la consultora de UNFPA.